

Procedimiento ordinario nº 1/0000395/2025
N.I.G: 28079 13 3 2025 0000680

**A LA SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPREMO (SECCIÓN CUARTA)**

MANUEL SÁNCHEZ-PUELLES GONZÁLEZ-CARVAJAL,
Procurador de los Tribunales y de “ASOCIACION CANNABIS HUB”, según
se tiene debidamente acreditado en estos autos, ante la Sala comparezco y como
mejor proceda en Derecho, **DIGO**:

Que, cumplimentando el traslado conferido por medio de Diligencia de
Ordenación de 6 de febrero de 2026, dentro del plazo a tal efecto concedido, por
medio del presente escrito, procedo a formalizar la **DEMANDA** con
fundamento en los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- MARCO GENERAL: LA CONVENCIÓN DE 1961 Y EL
CONVENIO DE 1971.

En España la regulación del cannabis parte necesariamente de la
Convención Única de Naciones Unidas de 1961 sobre Estupefacientes y del
Convenio de 1971 sobre Sustancias psicotrópicas.

La primera de ellas, la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes,
pretende limitar el uso de estupefacientes a fines exclusivamente médicos; y,
para ello, establece un sistema de control de su producción, comercio,
importación y exportación para combatir el tráfico ilícito.

La norma clasifica las sustancias en cuatro listados y somete a las sustancias incluidas en cada listado a unas mismas limitaciones: (i) la Lista I incluye las sustancias con un alto potencial de abuso, a las que se les reconoce un uso médico limitado y controlado (por ejemplo, morfina o heroína); (ii) la Lista II incluye sustancias con un menor riesgo que la Lista I y, por ello, se sujeta a un uso médico más común (por ejemplo, la codeína); (iii) la Lista III incluye sustancias con bajo riesgo de abuso y, por ende, sometidas a ciertos controles simplificados; y, (iv) la Lista IV, que es un subconjunto de la Lista I, incluye las sustancias especialmente peligrosas, con escaso valor terapéutico (por ejemplo, la heroína).

La segunda de ellas, el Convenio de 1971 sobre Sustancias psicotrópicas, adopta un esquema similar. En ella también se clasifican las sustancias psicotrópicas en cuatro grupos y, en función del grupo al que pertenecen, las sustancias se someten a un mayor o menor grado de fiscalización. En este caso, hablamos de sustancias psicotrópicas, es decir, sustancias que afectan a funciones psíquicas como el ánimo, la percepción o la conducta y que pueden ser estimulantes, depresoras o alucinógenas; mientras que antes hablábamos de estupefacientes, sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central produciendo, por lo general, un efecto de analgesia o sedación.

En concreto, los psicotrópicos se clasifican de la siguiente forma: (i) la Lista I incluye las sustancias con un alto riesgo, sin uso médico reconocido (por ejemplo, LSD o MDMA); (ii) la Lista II incluye las sustancias con un riesgo elevado, que aunque sí admiten su uso médico, éste es muy limitado (por ejemplo, metanfetamina); (iii) la Lista III incluye las sustancias con riesgo moderado de uso médico más frecuente (por ejemplo, barbitúricos); y, (iv) la Lista IV incluye las sustancias con menor riesgo y amplio uso terapéutico (por ejemplo, benzodiacepinas).

Ambas definiciones por listados - la de estupefacientes y la de psicotrópicos - han sido asimiladas por el Derecho de la UE a través de la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico de drogas.

SEGUNDO.- REPLANTEAMIENTO TRAS EL INFORME DE LA OMS Y LA DECISIÓN COMÚN DE LA UE.

Durante los últimos años, se ha avanzado notablemente en el estudio y comprensión del cannabis y de sus componentes. Fruto de estos avances, en 2020 la OMS aboga por excluir el cannabis de la Lista IV de estupefacientes al entender que *“el cannabis y la resina de cannabis no tienen una capacidad particular de provocar efectos perjudiciales similares a los provocados por las demás sustancias incluidas en la Lista IV de la Convención sobre Estupefacientes”*; y, que, además, *“ciertos preparados orales de cannabis han mostrado posibilidades de uso terapéutico en el tratamiento del dolor y otras afecciones médicas, como la epilepsia o los espasmos asociados a la esclerosis múltiple”* (Considerando 9 de la Decisión (UE) 2021/3 del Consejo).

Por ello, *“la OMS ha concluido que la inclusión del cannabis y la resina de cannabis en la Lista IV de la Convención sobre Estupefacientes no es compatible con los criterios de inclusión de una droga en dicha lista”* (Considerando 10 de la Decisión (UE) 2021/3 del Consejo).

Como se sabe, los principales compuestos del cannabis son el **CBD** (cannabidiol), que es un cannabinoide no psicoactivo en el sentido de la

Convención; y, el **THC** (Δ 9-tetrahidrocannabinol), que es el cannabinoide responsable del efecto psicoactivo.

El CBD no es susceptible de abuso ni de causar dependencia y no se encuentra incluido en ninguna de las listas de la Convención de 1961 ni de las del Convenio de 1971.

El THC sí se encuentra incluido en la Lista II del Convenio de Sustancias psicotrópicas, aunque la OMS ha abogado igualmente por reducir su fiscalización. Por ello, *“la OMS ha recomendado que el delta-9-tetrahidrocannabinol y su estereoisómero activo dronabinol se incluyan en la Lista I de la Convención sobre Estupefacientes y, de adoptarse dicha recomendación, que se eliminen de la Lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas”* (Considerando 14 de la Decisión (UE) 2021/3 del Consejo).

El razonamiento de la OMS para propugnar un cambio normativo descansaba en que carece de sentido que una sustancia y su principio psicoactivo se sometan a diferentes regímenes jurídicos, en este caso, una a la Convención de 1961 y el otro al Convenio de 1971 (véase la posición del Comité de Expertos de la OMS en los **folios 3317 y ss. del expediente**).

De hecho, al hilo de esas recomendaciones de la OMS, se inició un proceso de negociación entre los Estados signatarios de sendos convenios internacionales para valorar la conveniencia, o no, de su modificación.

Dado que la UE carece de derecho de voto en el seno de dichos Convenios en el año 2021, el Consejo adoptó una posición común sobre cómo votarían los países miembros de la UE respecto del cannabis y sus posibles modificaciones en los tratados internacionales.

Dicho proceso decisorio culminó en la Decisión (UE) 2021/3 del Consejo de 23 de noviembre de 2020 (documento nº 1) sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la continuación del sexagésimo tercer período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes sobre la inclusión del cannabis y de las sustancias relacionadas con el cannabis en las listas de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.

En concreto, la posición de la UE evidenciada en dicha Decisión se concretó, en cuanto aquí interesa, la siguiente:

“1) El cannabis y la resina de cannabis deben suprimirse de la Lista IV de la Convención sobre Estupefacientes.

2) El dronabinol y sus estereoisómeros (delta-9-tetrahidrocannabinol) debe añadirse a la Lista I de la Convención sobre Estupefacientes y, de adoptarse esta recomendación, debe suprimirse de la Lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas.”

La posición de la UE hacia la reducción de la fiscalización del cannabis y, en menor medida, del THC, es meridianamente clara. Una posición que, por lo demás, es vinculante para los Estados miembros, entre los que indudablemente se encuentra España.

TERCERO.- CREACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DEL CONGRESO Y TRABAJOS PREVIOS.

Poco después, el 10 de junio de 2021 se creó en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados una subcomisión al objeto de analizar las experiencias en la regulación del cannabis de uso medicinal.

El resultado del trabajo de dicha subcomisión se condensa en las siguientes recomendaciones (**folios 3263 y ss. del expediente**):

“1.1 Hay que preservar la respuesta apropiada a las peticiones de comercialización de medicamentos con productos derivados del cannabis en su composición, de acuerdo con los principios regulatorios que están en la base del funcionamiento de la AEMPS.

1.2 Se han de explorar fórmulas que permitan la disponibilidad en el mercado farmacéutico de extractos o preparados estandarizados del cannabis que hoy no tienen una autorización de comercialización para poder dar respuesta a aquellos pacientes a los que se les prescriba a través de los canales establecidos, que puedan conllevar una mejora frente al tratamiento establecido. En relación a otras opciones, los extractos o preparados estandarizados pueden aportar garantías de composición, dosificación, y seguridad.

1.3 En nuestro contexto, disponer de extractos o preparados estandarizados de cannabis como los que están disponibles en otros países europeos, podría permitir dar respuesta a estas necesidades. La existencia de preparados estandarizados, con una composición definida, supone una ventaja en términos de dosificación, estabilidad y manejo. A su vez, se valorará el desarrollo de proyectos experimentales cuando sean solicitados como las sumidades floridas de cannabis o con preparados de otro tipo que estén disponibles en países de la Unión Europea.

1.4 Debería valorarse la manera de que los servicios de farmacia competentes puedan elaborar fórmulas magistrales a partir de extractos o preparados estandarizados de cannabis para su uso directo en determinados casos, asegurando su estabilidad y uniformidad.

1.5 A partir de estas conclusiones y recomendaciones, y en un plazo de 6 meses desde la aprobación de este Informe por la comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, la AEMPS realizará los trabajos necesarios para que las citadas recomendaciones tengan encaje en la normativa y sean viables, permitiendo la disponibilidad en el mercado farmacéutico de extractos o preparados estandarizados del cannabis.”

CUARTO.- TRAMITACIÓN DEL REGLAMENTO: EL PRIMER BORRADOR Y SU POSICIÓN CLARAMENTE RECELOSA.

En este contexto normativo el Ministerio de Sanidad abrió el correspondiente periodo de consulta pública desde el 13 de febrero y hasta el 4 de marzo de 2024 (**folios 1657-3178 del expediente**).

Posteriormente, el Consejo de Ministros elaboró un primer borrador del Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las condiciones para la

elaboración y dispensación de fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados de cannabis (**folios 1-11 del expediente administrativo**).

Dicho borrador, sin embargo, distaba con mucho del espíritu aperturista que supuestamente declamaba:

Primero, su artículo 2 definía los componentes del cannabis y sus preparados estandarizados en términos sumamente amplios, con el claro objetivo de someterlos a una intensa fiscalización.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de este real decreto, se entenderá por:

- a) Preparado estandarizado de cannabis: producto con una cantidad definida de THC y/o CBD, que contiene uno o más extractos estandarizados de cannabis, y que ha sido registrado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con el objeto de ser empleado en la elaboración de una fórmula magistral tipificada.
- b) Cannabinoides: compuestos orgánicos, pertenecientes al grupo de los terpenofenoles, presentes en el cannabis y responsables de sus principales efectos farmacológicos.
- c) Delta-9-tetrahidrocannabinol (THC): cannabinoide componente del cannabis, presente en cantidad variable, principal sustancia química responsable de sus efectos psicoactivos y que tiene la consideración legal de psicótropo, incluido en la lista II del anexo 1 del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación.
- d) Cannabidiol (CBD): cannabinoide componente del cannabis, presente en cantidad variable, sustancia química responsable de distintos efectos farmacológicos.
- e) Fórmula magistral tipificada: es la fórmula magistral recogida en el Formulario Nacional, por razón de su frecuente uso y utilidad

Segundo, sus artículos 3 y 5 fijaban, un grado de fiscalización muy superior al de la posición común de la UE en la materia; y, en particular, el artículo 3.2 introducía innovativamente un umbral determinante a estos efectos, el del 0,2% de contenido de THC en peso.

Artículo 3. Condiciones de fiscalización del cannabis y los preparados estandarizados de cannabis.

1. El cannabis, independientemente de su contenido en cannabinoides, se considera un estupefaciente, al estar incluido en la Lista I anexa a la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 17/1967, de 8 de abril, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes, y adaptándolas a lo establecido en el convenio de 1961 de las Naciones Unidas. Por tanto, está sometido a las medidas de control y restricciones previstas en la citada Ley 17/1967, de 8 de abril.
2. Los preparados estandarizados de cannabis con un contenido de THC igual o superior a 0,2% en peso, serán considerados psicótrópos y estarán sometidos a las medidas de control y restricciones derivadas del Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas, previstas en el Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre..

Artículo 5. Obligaciones de los laboratorios farmacéuticos fabricantes de los preparados estandarizados de cannabis.

1. Los laboratorios farmacéuticos autorizados fabricantes de los preparados estandarizados de cannabis deberán realizar todas las operaciones de fabricación y/o control de los mismos de conformidad con las normas de correcta fabricación de medicamentos de la Unión Europea.
2. Los laboratorios farmacéuticos fabricantes tienen la obligación de asegurar el cumplimiento de las normas de correcta fabricación y buenas prácticas de distribución por los proveedores o fabricantes de materiales de partida empleados en la fabricación de los preparados estandarizados. A tal fin, se deberán auditar a intervalos regulares a dichos proveedores o fabricantes. Deberán, asimismo, documentar la cadena de suministro de cada material de partida, que deberá tener un origen lícito y cumplir con la legislación aplicable a las sustancias estupefacientes y/o psicótrópas, según proceda.
3. Los laboratorios farmacéuticos autorizados fabricantes de los preparados estandarizados, únicamente podrán suministrar dichos preparados a servicios de farmacia hospitalaria legalmente establecidos, o bien para exportación.
4. Cuando estos preparados se consideren psicótrópos en virtud de su contenido en THC, conforme al artículo 3, los laboratorios farmacéuticos fabricantes deberán contar con la correspondiente autorización conforme a lo previsto en el Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre.
5. Así mismo, cuando estos fabricantes hayan obtenido preparados psicótrópos a partir de sustancias estupefacientes (cannabis) deberán contar con la correspondiente autorización conforme a lo previsto en la Ley 17/1967, de 8 de abril.

Y, tercero, sus artículos 8 y 9 reconocían, de manera exclusiva e injustificada, la capacidad de los servicios de farmacia hospitalaria para elaborar y dispensar fórmulas magistrales, en claro detrimento de las comunitarias.

Artículo 8. *Elaboración de fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados de cannabis por servicios de farmacia hospitalaria.*

1. La elaboración de las fórmulas magistrales tipificadas se limitará a los servicios de farmacia hospitalaria legalmente establecidos, que dispongan de los medios necesarios para su preparación de acuerdo con las exigencias establecidas en el Formulario Nacional y en las normas de correcta elaboración y control de calidad que reglamentariamente se establezcan.
2. Aquellos preparados estandarizados que se consideren psicótrópos, por su contenido en THC, así como las fórmulas magistrales que se elaboren con ellos, se regirán por su normativa específica.

Artículo 9. *Condiciones de dispensación y seguimiento farmacoterapéutico.*

1. La dispensación, a pacientes ingresados o a pacientes externos, se realizará por los servicios de farmacia hospitalaria, que prestarán atención farmacéutica y, en colaboración con el equipo médico, realizarán el seguimiento integral del paciente.
2. Periódicamente se evaluará la necesidad de continuar con el tratamiento, en función del beneficio clínico obtenido y de la aparición de reacciones adversas.

QUINTO.- EVOLUCIÓN DEL REGLAMENTO: LAS CRÍTICAS INICIALES DEL MAPA Y DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

Ese primer borrador, junto con su correspondiente memoria de análisis de impacto normativo (**folios 1-39 del expediente**), fue sometido a informe de la Comisión Ministerial de Administración Digital (**folios 611-612 del expediente**), de la Oficina Presupuestaria del Departamento (**folios 613-616 del expediente**) y de la Secretaría General Técnica (**folios 617-625 expediente**); así como del resto de departamentos ministeriales (**folios 626 a 700 del expediente**), del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (**folios 1633-1634 del expediente**) y del Consejo Español de Drogodependencia y otras Adicciones (**folios 1636-1655 del expediente**).

De entre todos ellos, conviene destacar el contenido del Informe emitido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), de 13 de mayo de 2025 (**folios 654-666 del expediente**). En él se advierte, en primer lugar, que el artículo 3.1 excedía el ámbito de aplicación de la norma al intentar fiscalizar de forma general el cannabis; y, en segundo lugar, que el artículo 3.2 introducía

un umbral (0,2% de THC) que no tenía cobertura legal alguna y que, además, contradecía lo dispuesto en el artículo 4.4 del Reglamento (UE) 2021/2115, que cifraba ese límite en 0,3%.

El informe del MAPA propone suprimir el artículo 3.1 y modificar el artículo 3.2 para, por un lado, clarificar que la norma regula única y exclusivamente el cannabis que va a ser utilizado en la elaboración de fórmulas magistrales; y, por otro lado, adaptar el umbral fijado a los estándares europeos, para evitar una situación de inseguridad jurídica (**folios 654-666 del expediente**).

Se propone, por lo tanto, suprimir el apartado 1 del artículo 3 (pues no procede dado el ámbito de este real decreto) y modificar el apartado 2, con el objetivo de que quede manifiestamente claro que lo establecido en este artículo se refiere única y exclusivamente al cannabis que va a ser utilizado en la elaboración de fórmulas magistrales de preparados estandarizados de cannabis y al objeto de garantizar la calidad farmacológica de los mismos y que, en ningún caso, sirva de base normativa para ninguna actuación más allá del ámbito que propiamente le compete a la norma.

Asimismo, convendría fijar una regulación clara que permita a los cultivadores conocer el marco normativo en que deba llevarse a cabo su actividad, incluidas las actuaciones posteriores, como el transporte o transformación, de modo que una posible futura regulación del cáñamo industrial recoja los límites y condiciones para la totalidad de su planta, sumidades floridas incluidas, cuando su contenido en THC sea igual o inferior al límite que, en el marco de los citados reglamentos, sea pertinentemente considerado en dicha posible futura regulación en torno al cannabis (a la planta entera, sumidades floridas incluidas) sin efectos psicotrópicos, es decir, siempre y cuando se encuentre por debajo de los citados límites.

Desde el 30 de septiembre y hasta el 21 de octubre de 2024, el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las condiciones para la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados de cannabis y su memoria de análisis de impacto normativo fueron sometidos al correspondiente trámite de información pública en el portal web del Ministerio de Sanidad (**folio 787 del expediente**).

Durante ese periodo, fueron muchas las alegaciones presentadas (**folios 788-1632 del expediente**). Aportamos a continuación un cuadro en el que se

resume el contenido de las alegaciones que, a nuestros efectos, resultan más relevantes:

Sujeto que formula las alegaciones	Contenido de las alegaciones	Folio
European Industrial Hemp Association (EIHA)	La norma (i) introduce un concepto de cannabis erróneo, que contradice la posición de la Comisión Europea, en tanto que lo considera estupefaciente independientemente de cual sea su contenido en cannabinoides; (ii) considera también como estupefaciente el CBD, en contra de la postura sostenida por la Comisión Europea, que utiliza el término “novel food” y no el de “estupefaciente” para referirse a él; (iii) fiscaliza, indirectamente el cáñamo y todos sus derivados, precisamente por la definición de cannabis que introduce, a pesar de que la Convención de 1961 no se refiere a esas sustancias; y, (iv) introduce un umbral del 0,2% en THC superior al que se utiliza por las normas comunitarias (0,3%) y superior también al que se utiliza en otros Estados (0,3% en Canadá, Austria y República Checa; o, 1% en Suiza).	804 - 824
Asociación de Farmacéuticos Formulistas Profesionales Independientes (APROFARM)	La norma, en sus artículos 8 y 9, excluye injustificadamente a las oficinas de farmacia comunitarias de la elaboración y dispensación de estas fórmulas magistrales elaboradas con preparados estandarizados del cannabis, a pesar de que cumplan los requisitos establecidos al efecto para elaborar y dispensar medicamentos y otras fórmulas magistrales.	832 - 837
Sociedad Española del Medicamento Individualizado (LASEMI)	La norma excluye injustificadamente a las oficinas de farmacia comunitarias de la elaboración y dispensación de estas fórmulas magistrales, a pesar de que dicha exclusión no se desprende de las conclusiones de la Subcomisión; máxime cuando las farmacias comunitarias forman parte de la red de farmacias del sistema de salud (artículo 33 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud).	852 - 870
Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP)	La norma excluye a las oficinas de farmacia, que cumplen los requisitos establecidos para funcionar dentro del Sistema Nacional de Salud, de la posibilidad de elaborar y dispensar estas fórmulas magistrales, en contra de los principios de accesibilidad y equidad.	892 - 894
Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM)	La norma excluye tanto a las oficinas de farmacia como a los médicos de atención primaria debido a que las primeras son excluidas de la posibilidad de elaborar y dispensar estas fórmulas magistrales y los segundos son excluidos de la posibilidad de prescribir, lo que dificulta injustificadamente su acceso por parte de los pacientes.	959 - 963
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOV)	La norma impide injustificadamente la elaboración y dispensación de estas fórmulas magistrales por parte de las oficinas comunitarias de farmacia.	973 - 976

Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC)	La norma contraviene el Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, porque allí no se establece ninguna distinción entre las farmacias hospitalarias y las comunitarias; y, sin embargo, la norma sí excluye a las comunitarias de la posibilidad de elaborar y dispensar estas fórmulas magistrales aun cuando se trate de pacientes externos (no hospitalizados).	977 - 981
Consejo General de Colegios Farmacéuticos	La norma contraviene (i) el artículo 3.6 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que prevé la capacidad de las oficinas de farmacia para dispensar medicamentos, excepto en una serie de supuestos en los que no encaja adecuadamente el supuesto aquí suscitado; y (ii) el artículo 1.5 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia, que prevé la posibilidad de que las oficinas de farmacia hagan seguimiento farmacológico, aunque el fármaco haya sido recetado por un especialista hospitalario. Además, (iii) se apunta la idea de que, en otros Estados de la UE, son las farmacias comunitarias quienes la están dispensando.	985 - 1001
Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE)	La norma impide que las farmacias comunitarias intervengan en la formulación, a pesar de que son varias las normas que les habilitan: la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia; la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias; el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; y, el Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales, por sólo mencionar algunas de las normas de carácter estatal. Además, las oficinas de farmacia pueden realizar formulaciones con sustancias psicotrópicas y estupefacientes a la luz del Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero.	1021 - 1029
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)	El artículo 3 de la norma confronta con un comunicado de la AEMPS, que se recoge en las propias alegaciones y dice lo siguiente: <i>“Hay un cambio de tendencia de la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) con relación a la consideración de los medicamentos con cannabis o sus extractos. La JIFE es la Comisión de Estupefacientes de la ONU, esta comisión (de la que España forma parte) es la responsable de establecer las condiciones de fiscalización de las sustancias. Como resultado de este cambio de orientación en la fiscalización, los medicamentos con THC extraído de la sumidad florida de cannabis dejan de ser estupefaciente y pasan a ser psicótrópos, y los medicamentos con cannabidiol dejan de ser estupefacientes y dejan de tener consideración singular, son medicamentos digamos así, normales. Tanto el Sativex® como el Epidyolex®</i>	1034 - 1040

	<i>dejarían de estar cubiertos por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes (CU1961). Por tanto, Epidyolex no es ni estupefaciente ni psicótropo, y Sativex pasa a ser psicótropo.”.</i>	
Sociedad Española de Neurología	La norma debería permitir la posibilidad de que las farmacias comunitarias también participaran de la elaboración y dispensación de estas fórmulas magistrales.	1051 - 1054
International Center for Ethnobotanical Education, Research & Service (ICEERS)	La norma establece un límite de 0,2% de THC en su artículo 3 atenta contra el principio de seguridad jurídica y evidencia la intención de la Administración de que la norma vaya más allá de su ámbito de aplicación. En concreto, en las alegaciones se dice lo siguiente: “ <i>En este sentido, nos preocupa el límite establecido mediante el Artículo 3 de calificar como psicótropo cualquier preparado que supere el 0.2% de THC en las fórmulas magistrales. Los psicótopos están regulados por el Convenio de 1971 ratificado por España en 1977. En dicho convenio, por sustancia sicotrópica se entiende cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural de la Lista I, II, III o IV; y, por preparado se entiende toda solución o mezcla, en cualquier estado físico, que contenga una más sustancias sicotrópicas. Es decir, los psicótopos son principios activos, en este caso el THC, y un preparado sería una solución o mezcla realizada con THC. Un producto que contenga, por ejemplo, un 0,3% de THC no parece que se ajuste ni al concepto de psicótropo ni al de preparado. Los preparados se realizan para aprovechar el principio activo. No parece una forma muy eficiente de aprovechar el principio activo un producto en el que en el 99,7% del mismo no hay principio activo. Parecería que el objetivo de este Artículo 3 es regular fenómenos que van más allá del objeto de este Real Decreto, como sería por ejemplo el mercado de CBD en España. Lo cual resultaría en una extralimitación de la norma.”.</i>	1138 - 1145
European Medical Cannabis Association	La definición de cannabis prevista en la norma debería adaptarse a la nueva posición de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (2020), respaldada también por España.	1147 - 1149
Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis	La norma (i) no delimita de forma clara cuál es su ámbito de aplicación, generando inseguridad jurídica; (ii) establece un régimen de fiscalización injustificadamente más elevado que el que se desprende de los Tratados Internacionales en la materia; (iii) incorpora unas definiciones excesivamente amplias, que generan inseguridad jurídica; (iv) establece un límite 0,3% de THC en su artículo 3 que no se adecúa a los estándares internacionales; y, (v) limita injustificadamente la elaboración y dispensación de estas fórmulas magistrales tan sólo a las farmacias hospitalarias, en detrimento de las farmacias comunitarias.	1563 - 1584

Las anteriores alegaciones, presentadas por diferentes entidades y asociaciones del sector, son también compartidas por numerosas empresas y pacientes, que han incidido también en la excesiva fiscalización que impone la norma al introducir definiciones que no son acordes a los Convenios internacionales firmados en la materia (**folios 847-851 del expediente**) y en la injustificada limitación que establece la norma al no permitir que las farmacias comunitarias participen en la elaboración y dispensación de estas fórmulas magistrales (**folios 875-879, 838-846, 881-884, 886-888, 895-899 y 909-916 del expediente**).

SEXTO.- DESARROLLO DEL REGLAMENTO: LAS CRÍTICAS DE LAS CC.AA.

En fecha 3 de octubre de 2024, ambos documentos se remitieron también a las Comunidades Autónomas para que, en su caso, formularan las correspondientes alegaciones (**folios 717-786 del expediente**). Y, posteriormente, se abordó la elaboración de este reglamento en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (**folios 701-716 del expediente**).

Varias Comunidades Autónomas apuntaron serios problemas:

La Comunidad Foral de Navarra solicitó que las oficinas de farmacia comunitarias también puedan participar en la elaboración y dispensación de estas fórmulas magistrales (**folios 718-719 del expediente**).

La Comunidad de Madrid cuestiona la previsión del silencio negativo que establece la norma (**folios 723-736 del expediente**).

La Comunidad de Castilla-La Mancha propone establecer definiciones más claras, que permitan acotar adecuadamente el ámbito de aplicación de la norma (**folios 743-746 del expediente**).

La Comunidad Valenciana, que apunta la necesidad de clarificar el ámbito de aplicación de la norma y las definiciones que en ella se contiene (**folios 747-750 del expediente**).

El País Vasco solicita que las definiciones hagan referencia a las Convenciones Internacionales aprobadas en la materia y que se permita participar a las oficinas de farmacia en plano de igualdad con las farmacias hospitalarias (**folios 759-764 del expediente**).

SÉPTIMO.- SUPRESIÓN DEL ARTÍCULO 3.1 DEL REGLAMENTO Y DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO.

Como hemos expuesto, tras analizar el proyecto normativo y su memoria de análisis de impacto normativo, varios Ministerios, una parte importante de las Comunidades Autónomas y numerosas entidades, asociaciones y corporaciones dedicadas al uso terapéutico del cannabis, así como múltiples pacientes usuarios de estas sustancias, coincidieron en que el proyecto adolecía de importantes defectos.

Pese a todo ello, la Administración hizo caso omiso de la mayor parte de estas cuestiones y únicamente modificó parcialmente su artículo 3. La modificación fue la siguiente:

VERSIÓN ORIGINAL	VERSIÓN DEFINITIVA
Artículo 3. Condiciones de fiscalización del cannabis y los preparados estandarizados de cannabis. 1. El cannabis, independientemente de su contenido en cannabinoides, se considera un estupefaciente, al estar incluido en la Lista I anexa a la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 17/1967, de 8 de abril, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes, y adaptándolas a lo establecido en el convenio de 1961 de las Naciones Unidas. Por tanto, está sometido a las medidas de control y restricciones previstas en la citada Ley 17/1967, de 8 de abril. 2. Los preparados estandarizados de cannabis con un contenido de THC igual o superior a 0,2% en peso, serán considerados psicótropos y estarán sometidos a las medidas de control y restricciones derivadas del Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas, previstas en el Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre.	Artículo 3. Condiciones de fiscalización de los preparados estandarizados de cannabis. Los preparados estandarizados de cannabis con un contenido de THC igual o superior a 0,2 % en peso, serán considerados psicótropos y estarán sometidos a las medidas de control y restricciones derivadas del Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas, previstas en el Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación.

Dicho de otro modo: ante el aluvión de alegaciones que ponían negro sobre blanco las deficiencias del proyecto, la Administración se ha limitado a acometer una modificación puntual, quirúrgica, del artículo 3, eliminando su primer apartado.

Dicho precepto era uno de los más problemáticos, si se quiere, el que más evidenciaba que el objetivo de la Administración al elaborar la norma no ha sido sólo regular la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados del cannabis; pero no era el único. Los defectos de la norma subsisten tras la eliminación de ese apartado 1º del artículo 3, pues no es sólo que el resto de preceptos controvertidos se hayan mantenido inalterados; sino que, a mayor abundamiento, ese afán “extralimitador” de

regular el cannabis y sus componentes impregna toda la norma (y no sólo el apartado eliminado).

Obra en el expediente administrativo el Dictamen del Consejo de Estado (**folios 3179-3204**). Sorprendentemente, el informe no contiene ningún análisis de los artículos más importantes; sino que se ciñe a los artículos 4, 6 y 7, eludiendo un análisis detallado del resto de artículos.

Finalmente, el 9 de octubre de 2025 se publicó en el BOE el Real Decreto 903/2025, de 7 de octubre, por el que se establecen las condiciones para la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados de cannabis, aquí impugnado.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRELIMINAR.- Breve explicación de los motivos de impugnación y de la legitimación de la asociación CANNABIS HUB.

El objeto del presente recurso contencioso-administrativo lo constituye el Real Decreto 903/2025, de 7 de octubre, por el que se establecen las condiciones para la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados de cannabis. Más concretamente los artículos 2.a), 2.c), 2.d), 3, 5.2, 5.4, 5.5, 8 y 9.

Cuando hablamos de “*fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados del cannabis*” nos referimos al uso terapéutico de los principios activos de la planta del cannabis para elaborar medicamentos. Esta norma debe

regular, por tanto, únicamente el uso que se puede hacer de esas sustancias para elaborar medicamentos i) hechos “a medida” para un paciente concreto, ii) por parte de un farmacéutico, iii) siguiendo las prescripciones del Formulario Nacional y iv) para un uso específico.

Sin embargo, un análisis detallado de la norma evidencia que, en realidad, ésta va más allá de lo que se afirma en su objeto, incrementando el nivel de fiscalización sobre el cannabis en general a la vez que, supuestamente, abre la posibilidad de dispensar fármacos realizados conforme a fórmulas magistrales que contienen cannabis.

En efecto, como veremos a continuación, el Reglamento:

- (i) utiliza unos conceptos de cannabis y de sus componentes excesivamente amplios, lo que puede propiciar que la norma se acabe aplicando a ámbitos no directamente relacionadas con el uso terapéutico de estas sustancias;
- (ii) establece que todo preparado con un umbral de 0,2% de THC es un psicotrópico, lo que contraviene la normativa comunitaria, no tiene parangón en la experiencia comparada de otros Estados y resulta en una sobrefiscalización de estas sustancias que iba más allá de lo dispuesto en los Convenios internacionales ratificados por España en la materia; y,
- (iii) limita la elaboración y dispensación de estas fórmulas magistrales a las farmacias hospitalarias, en detrimento de las oficinas de farmacia comunitarias, lo pugna con el principio de proporcionalidad y necesidad.

Por todos estos motivos, la asociación Cannabis Hub ostenta legitimación activa para impugnar la norma que regula los preparados estandarizados de cannabis conforme al artículo 19.1.b) LJCA, en cuanto la disposición impugnada incide de manera directa y específica en los intereses colectivos cuya defensa constituye su objeto social.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene reiterando que la legitimación de las asociaciones no se condiciona a la titularidad de un derecho subjetivo propio; sino a la existencia de un interés legítimo colectivo, entendido como una relación material cualificada entre los fines estatutarios y el objeto del proceso, de tal modo que la eventual estimación del recurso comporte un beneficio real y cierto para el colectivo representado. Así lo declara, entre muchas otras, la Sentencia del Tribunal Supremo nº 378/2024, de 5 de marzo (rec. 7530/2022, ECLI:ES:TS:2024:1216).

En la misma línea, el Tribunal Supremo ha precisado que no es exigible que los estatutos de la asociación prevean de forma expresa la impugnación judicial de normas reglamentarias, siendo suficiente con que la regulación cuestionada afecte de manera relevante al sector o actividad cuya defensa asume la entidad. Esta doctrina ha sido reiterada recientemente en la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2026 (rec. 3623/2023, ECLI:ES:TS:2026:271).

Como veremos a lo largo del presente recurso, la norma aquí impugnada establece toda una serie de limitaciones a la libre circulación de productos de cannabis que presenten un porcentaje de THC superior al 0,2% que incide directamente en el núcleo de actividad investigadora, científica y regulatoria que define los fines de la asociación, lo que determina la concurrencia de un interés legítimo colectivo cualificado que legitima plenamente su acceso a la

jurisdicción contencioso-administrativa. Dicho de otro modo: los términos en que se encuentra regulado el Reglamento aquí impugnado pueden dar lugar a que todo producto mínimamente facturado que contenga más de 0,2% de THC se considere un preparado estandarizado de cannabis.

PRIMERO.- El artículo 2, apartados c) y d), así como, por relación, el apartado a), del Real Decreto 903/2025 son contrarios al Derecho de la Unión Europea.

Tal y como se ha explicado, el Real Decreto 903/2025, aquí impugnado, ha pretendido ir, desde su propia concepción, más allá de regular tan sólo la prescripción, elaboración, dispensación y uso de las fórmulas magistrales con preparados estandarizados del cannabis.

Buena prueba de ello son las definiciones de THC y de CBD que utiliza la norma impugnada en su artículo 2.c) y d). Estamos ante unas definiciones deliberadamente amplias, hasta el extremo de contravenir la jurisprudencia del TJUE en la materia.

1. La definición de THC que contiene el artículo 2.c) de la norma impugnada es contraria a la Decisión (UE) 2021/3 y a la jurisprudencia del TJUE en la materia.

El artículo 2.c) del Reglamento impugnado define el “Delta-9-tetrahidrocannabinol” o “THC” como aquel “*cannabinoide componente del cannabis, presente en cantidad variable, principal sustancia química responsable de sus efectos psicoactivos y que tiene la consideración legal de psicótropo, incluido en la lista II del anexo 1 del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales*

psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación”.

Según esta definición, cualquier sustancia que contenga THC es un psicótropo y, como tal, se encontrará sometido al Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, norma que fue aprobada por el Gobierno para adecuar la legislación española al Convenio sobre Sustancias psicotrópicas de 1971.

El problema que esconde esta definición es que, al definir el THC como psicótropo, lo que hace el Gobierno de España no sólo es desmarcarse de la noción que, en la actualidad, viene defendiendo unánimemente la UE; sino petrificarla.

Como ya hemos visto en la Decisión (UE) 2021/3 del Consejo, de 23 de noviembre (adjunta como documento nº 1), la UE propone, sobre la base de los avances científicos avalados por la OMS, eliminar el cannabis de la Lista IV de la Convención sobre Estupefacientes (1961); y, eliminar el THC de la Lista II del Convenio sobre Sustancias psicotrópicas (1971) para incluirlo en la Lista I de la Convención sobre Estupefacientes (1961).

Pues bien, frente a esta posición común, lo que acaba de hacer el Gobierno de España al aprobar el Real Decreto 903/2025 es definir el THC como psicótropo. De esta manera, esta sustancia continúa sometiéndose a las limitaciones que impone el Convenio sobre Sustancias psicotrópicas (1971), reduciendo así la Decisión (UE) 2021/3 a mero papel mojado.

No puede pasarse por alto que, según establece el artículo 288 TFUE, las decisiones son normas obligatorias en todos sus elementos, tal y como

reiteradamente viene recordando el TJUE (entre muchas otras, Sentencia de 6 de octubre de 1970, asunto 9/70, caso Franz Grad).

De hecho, de entre las numerosas resoluciones del TJUE que podríamos traer a colación, conviene destacar la reciente Sentencia de 27 de enero de 2026 (asunto C-271/23, caso Comisión c. Hungría), que se pronuncia precisamente sobre la citada Decisión (UE) 2021/3.

En aquel asunto, se discutía si Hungría había incumplido la Decisión (UE) 2021/3 al votar en contra de la posición común de la UE en la Comisión de Estupefacientes en la que se debatía la calificación del cannabis y de sus componentes. O, dicho de otro modo, si Hungría podía desvincularse de la posición común de la UE en la materia para seguir calificando al cannabis como estupefaciente y al THC como psicótropo. Obviamente, el TJUE sancionó tal infracción y refrendó la existencia de un incumplimiento.

No cabe, por tanto, la posibilidad de que un Estado miembro se desvincule, por sí y ante sí, de esa posición común vinculante. Una vez que el Derecho europeo asume como propio un concepto nuclear y lo define, los Estados miembros no pueden desvincularse de dicha definición. Conforme a la “teoría de los conceptos autónomos del Derecho europeo” estos conceptos, propios del Derecho europeo, deben ser interpretados y aplicados de manera uniforme, puesto que *“en el supuesto de (...) regirse por el Derecho interno, cada Estado tendría entonces la posibilidad de modificar el contenido del concepto”* y, *“si el contenido del término pudiera ser unilateralmente fijado y modificado por el Derecho interno”, “quedarían privados de todo alcance y las finalidades antes enunciadas del Tratado frustradas”* (por todas, Sentencia de 19 de marzo de 1964, asunto C-75/63, caso Unger).

La consecuencia práctica de todo ello es bien clara: España no puede desvincularse de la noción de cannabis y de sus componentes que, en materia de estupefacientes, ha establecido la Unión Europea en una posición común vinculante.

Es cierto que dicha posición no fue finalmente aprobada en el seno del Convenio y que, a día de hoy, el THC sigue siendo un psicótropo. Ahora bien, partiendo de esa base, la definición no era necesaria, pues ya obra en los tratados internacionales firmados por España.

Sin embargo, si la posición propugnada por la UE bajo la recomendación de la OMS finalmente prevalece y el THC es excluido del Convenio de 1971 e introducido en el de 1961 entonces la definición del reglamento devendrá de manera sobrevenida contraria a un tratado internacional con los múltiples problemas que ello acarrea. Buena prueba de ello es el apartado 8.2 del reglamento que dispone que *“Aquellos preparados estandarizados que se consideren psicótrópos, por su contenido en THC, así como las fórmulas magistrales que se elaboren con ellos, se regirán por su normativa específica”*.

El Reglamento está diseñando un sistema que gravita en torno al porcentaje de un elemento concreto, el THC, cuya caracterización y consecuencias psicoactivas a efectos de la Convención se encuentra en entredicho. Todas estas cuestiones deben ser analizadas, pues, en consonancia con el porcentaje límite del 0,2 % de THC que establece el artículo 3 del Reglamento y que analizaremos más adelante.

2. La definición de CBD que contiene el artículo 2.d) de la norma impugnada, por relación con el artículo 2.a), es contraria a la jurisprudencia del TJUE en la materia.

El artículo 2.d) define el “Cannabidiol” o “CBD” como aquel *“cannabinoide componente del cannabis, presente en cantidad variable, sustancia química responsable de distintos efectos farmacológicos”*. Nada se ocupa de concretar el precepto sobre los efectos farmacológicos a los que se refiere ni sobre su intensidad.

Sin embargo, la vaguedad de los términos en los que se define al CBD no es el único de los problemas. Junto a esa definición, el artículo 2.a) define los “preparados estandarizados de cannabis” como aquel *“producto con una cantidad definida de THC y/o CBD, que contiene uno o más extractos estandarizados de cannabis, y que ha sido registrado por la AEMPS, con el objetivo de ser empleado en la elaboración de una fórmula magistral tipificada”*. Esta última es una definición capital, puesto que, al fin y al cabo, la norma pretende, al menos así lo afirma su artículo 1, “establecer las condiciones de prescripción, elaboración, dispensación y uso” de dichas fórmulas magistrales tipificadas.

Dicho en otros términos: **la norma establece un régimen de fiscalización para controlar la prescripción, la elaboración, la dispensación y el uso de esa suerte de “medicamentos a medida” sea cual sea el contenido de CBD, los efectos que éste provoque y la intensidad de dichos efectos**. Y, decimos, “sea cual sea” precisamente porque la vaguedad de los términos en los que se enuncia el artículo 2.c) hace que entren dentro del ámbito de aplicación de la norma todos los usos del CBD.

Ello choca frontalmente con la jurisprudencia que el TJUE ha dictado en la materia por varias razones.

En primer lugar, porque el CBD no es un estupefaciente. La STJUE de 19 de noviembre de 2020 (asunto C-663/18, caso Kanavape) reconoce en términos meridianamente claros que el CBD no es ni un psicótropo sometido al Convenio de 1971 ni un estupefaciente sometido a la Convención de 1961. Extractamos el razonamiento del Tribunal, énfasis añadido:

“64. A este respecto, procede señalar que **ni el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas ni la Acción Común 97/396, a las que se hace referencia en el artículo 1, punto 1, letra b), de la Decisión Marco 2004/757, incluyen esta sustancia en su ámbito.**

[...]

71. En estas circunstancias, es cierto que una interpretación literal de las disposiciones de la Convención Única podría llevar a la conclusión de que, en la medida en que el CBD se extrae de una planta del género cannabis y que esta planta se utiliza en su totalidad, incluidas sus sumidades floridas o con fruto, este es un extracto de cannabis, en el sentido de la lista I de dicha Convención, y, por consiguiente, un «estupefaciente», en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra j), de la citada Convención.

72. No obstante, es preciso señalar que de los autos que obran en el Tribunal de Justicia y que se resumen en el apartado 34 de la presente sentencia se desprende que **el CBD controvertido en el litigio principal no parece tener efectos psicotrópicos ni nocivos para la salud humana sobre la base de los datos científicos disponibles.** Además, según estos elementos de los autos, la variedad de cannabis de la que se extrajo esta sustancia, que fue cultivada legalmente en la República Checa, tiene un contenido en THC que no supera el 0,2 %.

73. Pues bien, como se desprende del apartado 67 de la presente sentencia, la Convención Única se basa, en particular, en una finalidad de protección de la salud física y moral de la humanidad. Por consiguiente, debe tenerse en cuenta este objetivo al interpretar las disposiciones de dicha Convención.

[...]

76. De ello se deduce que **el CBD controvertido en el litigio principal no es un estupefaciente, en el sentido de la Convención Única.**”

Y ello, insistimos, porque el CBD no tiene efecto psicoactivo alguno en los términos de los Convenios, lo que determina que no tenga efectos nocivos

para la salud humana, según los datos científicos disponibles.¹ Sin embargo, la amplia definición de CBD y de preparado estandarizado del cannabis que utiliza la norma determina que se sujeten a idéntica fiscalización, por ejemplo, aquellos “medicamentos a medida” completamente inocuos, por contener únicamente CBD, y aquellos otros que sí puedan tener efectos psicoactivos (tanto mínimos como significativos).

No puede pasarse por alto que, insistimos, el CBD es un cannabinoide inocuo, que no tiene efecto psicoactivo alguno en los términos de los Convenios. Sobre esta cuestión puede verse el Informe elaborado en el año 2024 por Dña. Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, Catedrática de Derecho Penal y Directora de la Cátedra extraordinaria “Drogas Siglo XXI” de la UCM² (que adjuntamos como documento nº 2). En dicho Informe se analiza la regulación internacional y europea del cáñamo industrial y del CBD; y, en cuanto aquí interesa, reconoce la inocuidad del CBD a efectos de los Convenios. En concreto, en las páginas 31 y 51 del Informe se afirma lo siguiente:

“Como se viene indicando, ni el CBD es un estupefaciente -ni un psicotrópico-, ni la flor no psicoactiva está expresamente fiscalizada, muy al contrario, queda fuera de la dicción “*toda planta del género cannabis*” por su inocuidad e incapacidad para generar estupefaciente. Ni el CBD, ni la flor no psicoactiva están fiscalizadas”.

“El CBD natural obtenido de planta entera no tiene efectos psicotrópicos y no es nocivo para la salud humana, por lo que no debe considerarse un “extracto de cannabis” ni un estupefaciente conforme a la Convención Única de NN UU de 1961. Se parte de CBD natural de planta entera con cantidad mínima de THC que lo hace inocuo para la salud, tal como se deduce del actual conocimiento científico en la materia.”

¹ Es importante entender que muchas sustancias tienen efectos psicoactivos pero ello no significa que sean nocivos y por tanto fiscalizados dentro de los Convenios, piénsese por ejemplo en el café o el azúcar que evidentemente tienen efectos psicoactivos pero que nadie duda que se encuentran fuera de estos Convenios.

² MANJÓN-CABEZA OLMEDA, Araceli, La regulación internacional del cáñamo industrial y del CBD (cannabidiol) y en la normativa de la Unión Europea y consecuencias en la praxis española, 2024, Docta Complutense (accesible en <https://docta.ucm.es/entities/publication/9922c8b2-c131-49af-9322-83948e4e0fe9>)

La deliberada vaguedad de los términos que emplea la norma impugnada determina que se traten de forma idéntica sustancias con componentes y efectos muy distintos asimilando en la práctica el CBD a los estupefacientes. Asimilación que supone tanto como ignorar, una vez más, la jurisprudencia del TJUE en la materia (STJUE de 19 de noviembre de 2020, asunto C-663/18, caso Kanavape), que ya ha negado la mayor.

La definición de “preparado estandarizado de cannabis” contenida en el artículo 2.a) del Reglamento presenta un problema adicional de especial gravedad, al permitir una extensión indebida de dicho concepto hasta alcanzar a la propia planta de cannabis. En efecto, al definir el preparado estandarizado como un “*producto con una cantidad definida de THC y/o CBD*”, sin atender ni al proceso de obtención, ni a la naturaleza jurídica del objeto regulado, el precepto abre la puerta a que una planta de cannabis que haya sido genéticamente modificada o seleccionada para presentar un contenido concreto, estable y uniforme de THC pueda ser considerada, por el mero resultado final, un “preparado estandarizado” a efectos reglamentarios.

No estamos ante un argumento meramente teórico, en muchos Estados Miembros, se dispensan flores de cannabis – cannabis flos en la terminología de la farmacopea europea – como un medicamento (véase el documento nº 3), al considerarse que es estandarizable. Es más, en el propio expediente administrativo refleja el caso del señor Bryan Custodio, paciente con dolor crónico, que tiene prescrito en Portugal el medicamento Tilray Flor Seca THC 18, esto es, flor Cannabis sativa L. con 18% THC, aprobada por INFARMED y dispensada en farmacias comunitarias portuguesas con receta médica (documento nº4). Su solicitud de inclusión consta en las aportaciones de la consulta pública previa y fue rechazada por la Administración alegando la

"mayor dificultad de estandarización, dosificación y manipulación de la flor seca." Sin embargo, la monografía Cannabis flos 3028 de la Farmacopea Europea, documento nº 3, vigente desde julio de 2024, que el propio Anexo del Real Decreto 903/2025 exige cumplir distingue quimiotipos y establece márgenes de desviación del contenido declarado, de modo que la estandarización de flores no es, en sí misma, algo técnicamente ajeno al propio esquema que utiliza el Reglamento.

La posibilidad de que la propia flor pudiera considerarse un preparado estandarizado desdibuja por completo la distinción esencial entre planta, materia vegetal y preparado, y permite que una realidad estrictamente botánica o agrícola quede subsumida artificialmente en una categoría propia del ámbito farmacéutico. Este es solo un ejemplo más de los términos excesivamente amplios de la norma con la grave inseguridad jurídica que ello conlleva.

En segundo lugar, porque cuando la norma define al CBD atendiendo a los “distintos efectos farmacológicos” que produce lo que está haciendo es introducir lo que se conoce como “*definición por función*”; y, de nuevo, lo hace en contra de la jurisprudencia del TJUE.

En efecto, el TJUE ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el concepto de medicamento por “función” para afirmar con rotundidad que “*no puede calificarse sistemáticamente como medicamento por su función cualquier producto en cuya composición esté presente una sustancia que tenga un efecto fisiológico*” (entre otras, STJUE de 20 de abril de 2009, asunto C-27/08, caso BIOS). De esta manera, el TJUE veda la posibilidad de asignar una calificación jurídica (y, con ella, un determinado régimen de fiscalización) a todo producto por el mero hecho de que contenga una determinada sustancia e impone un análisis casuístico (“*la Administración competente, con la diligencia exigible,*

realice un examen caso por caso de cada producto, teniendo en cuenta en particular las propiedades farmacológicas, inmunológicas o metabólicas que le sean propias, hasta donde pueda determinarse en el estado actual de los conocimientos científicos”) (SSTJUE de 20 de abril de 2009, asunto C-27/08, caso BIOS; de 15 de enero de 2009, asunto C-140/07, caso Hecht Pharma; y, de 9 de junio de 2005, asuntos acumulados C-211/03, C-299/03 y C-316/03 a C-318/03, caso HLH Warenvertriebs).

Pues bien, lo que exige el TJUE es precisamente lo que no hace la norma al someter a fiscalización a todos los preparados estandarizados que contengan CBD; y, al definir a este cannabinoide por su función, de forma genérica, sin tener en cuenta cuáles son los concretos efectos farmacológicos que produzca en cada caso.

Y, en tercer lugar, porque dicha definición por función no sólo atiende únicamente a la utilización del CBD en el preparado estandarizado; sino que, además, prescinde por completo de la intensidad de los efectos que produce esa sustancia. No puede pasarse por alto que la jurisprudencia del TJUE en materia de medicamentos atiende a los concretos efectos fisiológicos que produce la sustancia caso a caso y también a su intensidad (*“procede recordar que el criterio de idoneidad para restablecer, corregir o modificar las funciones fisiológicas no debe conducir a calificar como medicamentos por su función aquellos productos que, si bien tienen cierta influencia en el cuerpo humano, carecen de efecto fisiológico significativo y, por tanto, no modifican n sentido estricto sus condiciones de funcionamiento”*) (SSTJUE de 20 de abril de 2009, asunto C-27/08, caso BIOS; de 15 de enero de 2009, asunto C-140/07, caso Hecht Pharma; y, de 9 de junio de 2005, asuntos acumulados C-211/03, C-299/03 y C-316/03 a C-318/03, caso HLH Warenvertriebs). Sin embargo, como

decimos, ninguna referencia hace la norma a la intensidad de esos “diversos efectos farmacológicos”.

En definitiva, el artículo 2.a) y d) de la norma impugnada define el concepto de “preparado estandarizado” y de “CBD” en términos tan amplios que incluye y fiscaliza cualquier “medicamento a medida” que contenga este cannabinoide, que -insistimos- es inocuo, con independencia de los efectos fisiológicos que produzca en cada caso y de la intensidad de esos efectos; asimilándolo, en la práctica, a un estupefaciente, lo que ya ha sido, todo ello, negado por el TJUE.

SEGUNDO.- El artículo 3, en la medida en que establece un porcentaje de un 0,2% de THC, que carece de fundamento legal y/o científico y contraviene el principio de cooperación legal, debe ser anulado.

Como ya hemos advertido, el artículo 3 del Real Decreto introduce por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico un umbral del 0,2% de THC en peso para clasificar los preparados estandarizados de cannabis como “psicótrpos”.

Ello supone someter a estos preparados a las medidas de control y restricciones previstas en el Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, que incorporó al ordenamiento español las medidas de fiscalización previstas en el Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas: dichas medidas incluyen, entre otras, importantes restricciones para la fabricación (artículos 6 a 9) e importación y exportación (artículo 10) de estas sustancias.

En consecuencia, el apartado 4 del artículo 5 del Real Decreto sujeta expresamente a los laboratorios que fabriquen los preparados que cumplan la

definición establecida en el artículo 3 a la obligación de obtener la autorización prevista en el Real Decreto 2829/1977.

El establecimiento de dicho umbral para clasificar los preparados estandarizados de cannabis como psicótropos no se encuentra amparado en la normativa nacional o internacional vigente, ni está respaldado por las recomendaciones más recientes de la comunidad científica internacional. Al contrario, vulnera directa o indirectamente el derecho estatal y el derecho de la Unión.

En efecto, durante la tramitación del Real Decreto, se requirió a la Administración en numerosas ocasiones para que justificara el novedoso establecimiento de este umbral, ya que, como constató el Informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, *“el límite del contenido en THC para ser considerado psicótropo no aparece especificado en ninguna norma española”* (**folio 661 del expediente**).

En respuesta a esta y otras muchas alegaciones similares, la Memoria de Análisis e Impacto Normativo se ampara en dos referencias. En primer lugar, se indica que dicho umbral coincide con el porcentaje de THC que contienen determinados medicamentos a base de cannabis como el Sativex, según los “ensayos clínicos” con los que cuenta la Administración (véase, en respuesta al Informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el **folio 604 del expediente**). Y, en segundo lugar, la Memoria cita repetidamente el 41º Informe del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, indicando lo siguiente:

“El Comité de Expertos en farmacodependencia de la OMS (ECDD) recomendó en su 41ª reunión que “Las preparaciones que contienen predominantemente cannabidiol y no más del 0,2 % de delta-9-

tetrahidrocannabinol no están bajo control internacional”. Este umbral de THC fue propuesto por expertos de la OMS refiriéndose al medicamento aprobado Epidiolex®/Epidyolex®, una preparación de la planta de cannabis que contiene trazas (no más del 0,15 % en peso) de delta-9-tetrahidrocannabinol (Δ 9-THC; dronabinol), sin efectos indicativos de potencial de abuso o dependencia ni efectos psicoactivos” (folios 503-504, 514, 517 del expediente).

Como veremos a continuación, la motivación realizada por el Ministerio no se corresponde con la realidad y tergiversa el informe del Comité de Expertos.

1. Los argumentos esgrimidos por la Administración carecen de apoyo fáctico y tergiversan la opinión del Comité de Expertos de la OMS.

Lo primero que se debe señalar es que ni los informes resultantes de estos “ensayos clínicos” ni el citado Informe del Comité de Expertos de la OMS – que constituyen el fundamento de uno de los aspectos más centrales del Real Decreto, como es el umbral establecido en el artículo 3 – fueron incorporados al expediente administrativo.

De hecho, tras ser requeridos por nuestra parte mediante solicitud de complemento del expediente, se hizo constar, mediante Oficio de la Secretaría General Técnica (DG/74/24), únicamente se aportó el informe del Comité de Expertos de la OMS, señalando que los informes resultantes de los “ensayos clínicos” a los que se hace referencia en el folio 604 no constan en el expediente administrativo (folio 3205 del expediente).

Por tanto, es evidente que dichos ensayos no constituyen ninguna base empírica cuando ni siquiera obran en el expediente.

Respecto del informe de la OMS, de la simple lectura del texto transcrito se puede observar que la Administración ha tergiversado el contenido y el objetivo de la recomendación. En efecto, debemos recordar que, mientras que los extractos vegetales de la planta de cannabis (*Cannabis Sativa L*) están fiscalizados bajo la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes (en la Lista I), el cannabis no se encuentra fiscalizado en el Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas, que solamente fiscaliza el THC y sus isómeros (mediante inclusión en las Listas I y II)³.

Las explicaciones del Comité sobre los preparados de cannabidiol (CBD) que justifican la recomendación a la que se refiere la Administración (**folio 3325 del expediente**) precisamente lo que ponen de relieve es que el CBD no tiene efectos psicoactivos y que el THC en dosis muy pequeñas tampoco los tiene:

“El cannabidiol se puede obtener mediante síntesis química o a partir de la planta de cannabis. El medicamento autorizado (Epidiolex®) es un preparado de la planta de cannabis. El Comité señaló que los medicamentos no tienen efectos psicoactivos y que se fabrican como preparados de la planta en cuestión que contienen cantidades ínfimas de Δ 9-THC (dronabinol). Epidiolex®, que es el preparado de cannabidiol autorizado para tratar la epilepsia infantil, contiene como máximo un 0,15% de Δ 9-THC en peso y no causa efectos indicativos de que se pueda utilizar indebidamente o causar dependencia. De conformidad con la recomendación formulada en la 40.^a reunión del CEFD de que **los preparados que se consideren cannabidiol puro no sean objeto de fiscalización**, el Comité reconoció que tales preparados contienen cantidades ínfimas de Δ 9-THC (como el 0,15% presente en Epidiolex®). También reconoció que, para algunos Estados Miembros, **puede ser difícil realizar análisis químicos que permitan detectar con exactitud concentraciones del 0,15% de Δ 9-THC, por lo que situó las capacidades nacionales de detección de las cantidades ínfimas de esta sustancia psicoactiva en un mínimo del 0,2%**”

Recomendación: el Comité recomendó **añadir una nota al pie a la Lista I del Convención Única sobre Estupefacientes de 1961** en la que se

³ Concretamente, el Δ 9-tetrahidrocannabinol está inscrito en la Lista II como dronabinol y sus estereoisómeros, mientras que los isómeros del tetrahidrocannabinol Δ 6a(10a)-tetrahidrocannabinol, Δ 6a(7)-tetrahidrocannabinol, Δ 7-tetrahidrocannabinol, Δ 8-tetrahidrocannabinol, Δ 10-tetrahidrocannabinol y Δ 9(11) tetrahidrocannabinol figuran en la Lista I (Informe del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, **folio 3306**).

indique lo siguiente: «Los preparados que contengan **predominantemente cannabidiol y no más de un 0,2% de delta-9-tetrahidrocannabinol no están sujetos a fiscalización internacional.**» (la negrita es nuestra).

Por tanto, lo que pretendía el Comité de Expertos de Farmacodependencia, al recomendar la exclusión del CBD de toda fiscalización internacional – por entender que el mismo no entraña ningún riesgo para la salud –, era simplemente excluir de la fiscalización del Convenio sobre Estupefacientes de 1961 a los preparados con un contenido de THC por debajo de un determinado umbral.

La Administración tergiversa esta recomendación para utilizar este mismo umbral con el objetivo contrario: incrementar la fiscalización del cannabis sometiendo por primera vez a los preparados de cannabis con un porcentaje superior al 0,2% de THC a la fiscalización del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.

La prueba última de un espíritu liberalizador se encuentra en los considerandos 25 a 28 de la Decisión (UE) 2021/3 del Consejo, que explican que la Posición Común de la Unión fue precisamente la de votar en contra de esta recomendación (la de excluir de toda fiscalización los productos con menos de 0,2% de THC) debido a la insuficiencia de base científica:

“(24) De acuerdo con el examen del Comité de Expertos de la OMS, el cannabidiol se encuentra en el cannabis y en la resina de cannabis pero no tiene propiedades psicoactivas ni puede provocar adicción o dependencia. Tampoco tiene efectos perjudiciales significativos. Además, el cannabidiol ha mostrado su eficacia en el tratamiento de ciertas patologías epilépticas resistentes a los tratamientos y que aparecen durante la infancia.

(25) La OMS señaló que los medicamentos sin efectos psicoactivos producidos como preparados de la planta de cannabis contienen trazas de delta-9-tetrahidrocannabinol y reconoció que el análisis químico del delta-9-tetrahidrocannabinol hasta una precisión del 0,15 % puede ser difícil para algunos Estados miembros. En consecuencia, la OMS ha recomendado que se añada a la entrada correspondiente al cannabis y la resina de cannabis de la

Lista I de la Convención sobre Estupefacientes una nota a pie de página del siguiente tenor: «Los preparados que contengan fundamentalmente cannabidiol y no más de un 0,2 % de delta-9-tetrahidrocannabinol no están sujetos a la fiscalización internacional».

(26) Sin embargo, esa recomendación reduciría el nivel actual de fiscalización de dichos preparados. Además, **el establecimiento de dicho límite del 0,2 % de delta-9-tetrahidrocannabinol no está suficientemente avalado por pruebas científicas**; el tenor de dicha recomendación no excluye posibles interpretaciones divergentes en cuanto a la forma de calcular el límite de 0,2 % de delta-9-tetrahidrocannabinol, y la ejecución técnica de dicha recomendación será difícil por razones de capacidad técnica y administrativa. El tratamiento diferenciado del cannabidiol en comparación con otros cannabinoides no es compatible con la estructura actual de las listas de la Convención sobre Estupefacientes y del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas. Dicha recomendación, tal como se ha redactado, no ofrece la seguridad jurídica necesaria.

(27) Por consiguiente, **la posición de la Unión debe ser la de votar en contra de la recomendación de añadir a la entrada correspondiente al cannabis y la resina de cannabis de la Lista I de la Convención sobre Estupefacientes una nota a pie de página relativa a los «preparados que contengan predominantemente cannabidiol y no más de un 0,2 % de delta-9-tetrahidrocannabinol».**

(28) Sin embargo, **la Unión apreciaría nuevas consultas con todas las partes interesadas en relación con una recomendación relativa al nivel adecuado de fiscalización internacional de los preparados del cannabis con bajo contenido de delta-9-tetrahidrocannabinol**, que vele al mismo tiempo por la protección de la salud pública y el bienestar, teniendo en cuenta la estructura existente del sistema internacional de fiscalización de drogas para el cannabis, así como la capacidad técnica y administrativa necesaria para la ejecución de dicha recomendación” (la negrita es nuestra).

Estas consideraciones son coherentes con la regulación del cannabis medicinal en otros países de nuestro entorno, que no incrementan la fiscalización del cannabis medicinal según la concentración de THC que contenga un preparado como explicaremos de seguido.

2. El porcentaje de 0,2% como parámetro de control del cannabis medicinal es totalmente contrario a la experiencia en otros países de la Unión.

Ni en su contestación a las alegaciones formuladas, ni en la MAIN, el Ministerio de Sanidad es capaz de citar ningún país de la Unión que siga un esquema similar al propuesto por España. Es más, es que es abiertamente opuesto al sistema francés o alemán.

En efecto, en el caso de Alemania, que reguló el cannabis medicinal mediante la Ley de Cannabis Medicinal *Medizinal-Cannabis-Gesetz* (“**MedCanG**”)⁴: esta norma sujeta a prescripción médica ordinaria – esto es, sin necesidad de una receta especial para preparados de psicótrópos ni de estupefacientes – la dispensación de cannabis, sin establecer ningún control adicional con base en el contenido de THC del preparado.

Por el contrario, dicho límite únicamente opera para el cannabis de uso lúdico y es de un 10% de THC. De este modo, el cannabis para uso recreativo se regula en una ley distinta, la Ley de Cannabis Recreativo *Cannabisgesetz* (CanG)⁵: en este caso, las autoridades alemanas han recomendado como orientación que se limite el consumo de cannabis con un contenido de THC del 10% para jóvenes de entre 18 y 21 años.

De manera similar, en Francia, el Decreto n.º 2022-194, de 17 de febrero de 2022 (*Décret relatif au cannabis à usage médical*)⁶ regula el cannabis medicinal sin establecer diferentes medidas de fiscalización según el contenido de THC. Por el contrario, el Decreto de 30 de 2021 (*Arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique*)⁷, que regula las condiciones para el cultivo de cáñamo industrial (*chanvre*) sí establece un umbral del 0,3% de THC por debajo del cual las flores de cáñamo

⁴ Véase [MedCanG - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis](#)

⁵ Véase <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/detail/cannabisgesetz>

⁶ Véase <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045185582>

⁷ Véase <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044793213>

no se considerarán estupefacientes (este umbral se fija con arreglo a la normativa europea para la importación de cáñamo industrial, que se detallará a continuación).

La razón por la que los países de nuestro entorno establecen esta diferencia para la regulación del cannabis medicinal y el tratamiento del cannabis en otros ámbitos es sencilla: el cannabis medicinal está sujeto a prescripción médica, y por ello existe un mecanismo mucho más adecuado para controlar su consumo, que es restringir la dosis. Esta es, en realidad, la verdadera razón por la que los medicamentos a base de cannabis como el Epidiolex y el Sativex se consideran seguros: no se trata de que su concentración de THC esté por debajo de un determinado umbral, sino de que un facultativo pueda controlar la dosis que se va a suministrar a cada paciente.

A título ilustrativo, para comprender por qué debe ser la dosis y no el porcentaje de THC el factor de control determinante, piénsese como ejemplo en el peligro para la salud derivado del consumo de bebidas alcohólicas. Mientras que el vino suele tener una concentración de alcohol (en volumen) de entre un 11 y un 15%, una cerveza suele tener una graduación de entre el 4 y el 5%. Sin embargo, nadie dudaría de que ingerir, por ejemplo, diez cervezas, es mucho más perjudicial para la salud que ingerir un vaso de vino. Exactamente lo mismo ocurre con el porcentaje de THC. Utilizar este porcentaje en abstracto sin tener en cuenta la dosis, ni el paciente es totalmente contradictorio con la buena praxis sanitaria.

3. El porcentaje del THC demuestra la finalidad claramente fiscalizadora de la norma.

¿Cuándo puede resultar razonable fiscalizar el cannabis según su porcentaje de THC? Únicamente cuando se trate de cannabis para usos no medicinales, esto es, usos no sujetos a una prescripción médica y que, por tanto, no permitan controlar la dosis que se va a ingerir, ni las características (peso, edad, salud de quien las va a consumir).

No debe olvidarse que este actual artículo 3 del Reglamento aquí impugnado venía precedido de un párrafo que fue finalmente eliminado y que disponía lo siguiente: *“El cannabis, independientemente de su contenido en cannabinoides, se considera un estupefaciente, al estar incluido en la Lista I anexa a la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 17/1967, de 8 de abril, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes, y adaptándolas a lo establecido en el convenio de 1961 de las Naciones Unidas. Por tanto, está sometido a las medidas de control y restricciones previstas en la citada Ley 17/1967, de 8 de abril.”*

Ello viene a evidenciar, como venimos diciendo, la finalidad claramente represiva de la norma.

Incluso cuando fuera relevante establecer un umbral de THC para determinar la fiscalización internacional aplicable a las variedades de cannabis, el consenso científico internacional se dirige al establecimiento de umbral por encima del 0,2%. Baste referirnos al ya citado informe de 2024 de la Catedrática de Derecho Penal Dña. Araceli Manjón-Cabeza Olmeda⁸, donde se explica que

⁸ MANJÓN-CABEZA OLMEDA, Araceli, La regulación internacional del cáñamo industrial y del CBD (cannabidiol) y en la normativa de la Unión Europea y consecuencias en la praxis española, 2024, Docta Complutense (accesible en <https://docta.ucm.es/entities/publication/9922c8b2-c131-49af-9322-83948e4e0fe9>)

el umbral más coherente con el sistema que establece la Convención de Estupefacientes de 1961 se situaría en un 1% (documento n° 2):

“Por otro lado, en este mismo Manual encontramos otras afirmaciones relevantes en la materia objeto de este Informe; así, se informa de la distribución de THC en la planta en el siguiente sentido:

“El contenido de THC varía en función de la parte de la planta de que se trate:

10 a 12% en las flores pistiladas

1 a 2% en las hojas

0,1 a 0,3% en los tallos

< 0,03% en las raíces”

Estos datos son relevantes a la hora de considerar cuál debería ser el porcentaje de THC permitido para considerar que una muestra es de cáñamo lícito. Los porcentajes de 0,1 e inferiores se corresponden con partes de la planta no fiscalizadas raíces y tallos-. En cuanto a las hojas, no se distingue entre las fiscalizadas -las unidas a las sumidades- o las que caen fuera de la fiscalización, pero en todo caso, si vamos al límite mínimo de la horquilla -de 1% a 2%-, parece que este debe corresponder a las hojas no fiscalizadas (1%), quedando el máximo para las hojas fiscalizadas (2%).

De esta manera, ese 1% de THC aparece como un posible porcentaje correcto para entender que estamos fuera de la fiscalización, porque si se opta por un porcentaje inferior se estarían incluyendo en el régimen de fiscalización todas las hojas, cuando lo cierto es que el art. 1.1.b) de la Convención Única de 1961 dice, literalmente, lo siguiente, como ya se ha visto más arriba: “Por “cannabis” se entiende las sumidades, floridas o con fruto, de la planta de la cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades)...” (el subrayado es mío)

Si las hojas no unidas a las sumidades contienen, como mínimo, un 1% de THC y esas hojas están expresamente excluidas de la fiscalización, entonces debe deducirse que ese 1% de THC debería ser el límite entre la fiscalización y la no fiscalización; se entiende entonces que algunos sistemas hayan optado por el 1%, y no por el 0,2% o 0,3%, a la hora de determinar el porcentaje máximo de THC que puede estar presente en una planta de cáñamo no psicoactiva”.

Dicho umbral se fija en relación con el ST/NAR/40, el manual de Naciones Unidas sobre métodos recomendados para la identificación y análisis del cannabis y sus productos que se acompaña como documento n° 5.

La monografía 3028 de la farmacopea europea a la que ya nos hemos referido, documento nº 3 utiliza el porcentaje del 1,0% como una referencia técnica relevante en la delimitación entre quimiotipos. La monografía 3028 distingue entre:

- THC-dominante: mínimo 5,0% THC, máximo 1,0% CBD.
- THC/CBD intermedio: mínimo 1,0% THC, mínimo 1,0% CBD
- CBD-dominante: máximo 1,0% THC, mínimo 5,0% CBD.

En cualquier caso, de lo que no puede caber ninguna duda es que el umbral de THC aplicable para determinar el control de un producto de cannabis no puede ser inferior al 0,3% de THC, pues este es el umbral actualmente vigente bajo la normativa europea a efectos de subvenciones, como veremos a continuación.

4. El porcentaje fijado contraviene la normativa europea, en concreto la Política Agraria Común.

El artículo 3 contraviene la normativa europea, en concreto, los Reglamentos (UE) nº 1308/2013 y 2021/2115, que regulan la ordenación del mercado interior en el marco de la política agrícola común (PAC) y establecen un límite del 0,3% de THC para la importación del cáñamo industrial en la Unión (que coincide con el límite de THC que se establece a su vez para obtener ayudas para el cultivo de cáñamo en el marco de la PAC).

Así lo resaltó también el Informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (**folios 661 y ss. del expediente**), así como muchas otras alegaciones. En respuesta, la Memoria de Análisis e Impacto Normativo se limita a indicar lo siguiente:

“El límite a que se refiere el artículo 3.2 del presente real decreto se refiere a la consideración como psicótropo de los preparados estandarizados de cannabis con un contenido de THC igual o superior a 0,2% en peso, no al cannabis, que de conformidad al artículo 3.1 se considera un estupefaciente, independientemente de su contenido en cannabinoides. Cabe destacar que **el límite de 0,3 % THC que establece el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021** por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n°. 1305/2013 y (UE) n°. 1307/2013 **no se establece para su consideración como estupefaciente, sino para las ayudas de la PAC**” (folios 484-485, 563-564 y 585-586; la negrita es nuestra).”

Esta afirmación sobre el alcance del límite del 0,3% de THC establecido en la normativa de la PAC aplicable al cáñamo industrial es incompleta y errónea, tal como ha clarificado la Comunicación de la Comisión del 6 de junio de 2023 por la que se aclara la legislación aplicable a los requisitos de importación del cáñamo y las semillas de cáñamo a que se refiere el artículo 189 del Reglamento (UE) n° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (C/2023/1365), que transcribimos a continuación:

“Contenido máximo de THC en el cáñamo y las semillas de cáñamo importados en la Unión.

- 1) El artículo 189, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 establece controles a las importaciones de cáñamo y semillas de cáñamo, respectivamente, para asegurar que se respetan determinadas garantías en relación con su contenido de tetrahidrocannabinol (THC). Su texto es el siguiente:
«Los productos siguientes únicamente podrán importarse en la Unión si se cumplen las condiciones que se enumeran a continuación:
 - a) cáñamo en bruto del código NC 5302 10 00 que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 32, apartado 6, y en el artículo 35, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013;
 - b) semillas para siembra de variedades de cáñamo del código NC 1207 99 20 que vayan acompañadas de un justificante de que el nivel de tetrahidrocannabinol de la variedad de que se trate no supera el valor

fijado de conformidad con el artículo 32, apartado 6, y el artículo 35, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013;».

- 2) Con estos controles se trata de garantizar que el cáñamo en bruto del código NC 5302 10 00 cumpla las condiciones establecidas en el artículo 32, apartado 6, y en el artículo 35, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 y que las semillas para siembra de variedades de cáñamo del código NC 1207 99 20 vayan acompañadas de un justificante de que el nivel de tetrahidrocannabinol de la variedad de que se trate no supera el valor fijado de conformidad con el artículo 32, apartado 6, y el artículo 35, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013.
- 3) En virtud del artículo 154, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/2115, queda derogado el Reglamento (UE) n.o 1307/2013 con efecto a partir del 1 de enero de 2023. El artículo 32, apartado 6, y el artículo 35, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 han sido sustituidos por el artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, y el artículo 4, apartado 8, del Reglamento (UE) 2021/2115.
- 4) El artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento (UE) 2021/2115 aumentó del 0,2 % al 0,3 % el nivel máximo permitido de THC del cáñamo cultivado en tierras que reúnan los requisitos para que se realicen pagos directos.
- 5) Por consiguiente, **el máximo permitido de THC en las importaciones de cáñamo del código NC 5302 10 00 y de semillas para siembra de variedades de cáñamo del código NC 1207 99 20 es del 0,3 % desde el 1 de enero de 2023.**
- 6) Las normas actualizadas sobre requisitos adicionales, sobre la verificación de las variedades de cáñamo y sobre la determinación cuantitativa del contenido de THC establecidas en actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartado 8, del Reglamento (UE) 2021/2115 (5) también se aplican a las importaciones de cáñamo del código NC 5302 10 00 y de semillas para siembra de variedades de cáñamo del código NC 1207 99 20 a partir del 1 de enero de 2023” (la negrita es nuestra).

Y, por si quedase alguna duda sobre el sentido y el objetivo de dicho límite, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de enero de 2003, dictada en el asunto C-462/01 (caso *Ulf Hammarsten*), estableció que una norma nacional que prohíba completamente el cultivo y posesión del cáñamo industrial es contraria al Derecho de la Unión, y ello debido a que las limitaciones establecidas en los Reglamentos de la UE para la concesión de ayudas de la PAC ya han tenido suficientemente en cuenta los riesgos para la salud humana que puede conllevar el uso de estupefacientes como el cannabis:

“30. Procede señalar, por una parte, que la prohibición que se deriva de la normativa sueca relativa a los estupefacientes de cultivar y poseer cáñamo industrial cubierto por una organización común de mercados en el sector del cáñamo afecta directamente a esta organización común.

31 En efecto, esta prohibición priva a los agricultores establecidos en Suécia de cualquier posibilidad de solicitar la ayuda que está prevista en el Reglamento n° 1308/70 y cuyas condiciones de concesión están determinadas por el Reglamento n° 619/71.

32. Debe señalarse, por otro lado, que la normativa sueca relativa a los estupefacientes no persigue un objetivo de interés general que no esté cubierto por la organización común de mercados en el sector del cáñamo.

33. El Gobierno sueco alega, a este respecto, que la normativa nacional controvertida es necesaria para lograr el objetivo de protección de la vida y la salud de las personas y que está justificada por el hecho de que el cannabis constituye un estupefaciente según la Convención de la Organización de Naciones Unidas de 1961 sobre estupefacientes. Según este Gobierno, las normas comunitarias en materia de agricultura, como las de la organización común de mercados establecida en el sector del cáñamo, tienen un objetivo distinto del perseguido por la normativa sueca, que es el de garantizar un nivel elevado de protección de la salud pública.

34. Sin embargo, **se desprende de los dos primeros considerandos del Reglamento n° 1430/82 que los riesgos para la salud humana que implica el uso de estupefacientes se tuvieron en cuenta expresamente en el marco de la organización común de mercados en el sector del cáñamo.**

35. En este sentido, el artículo 4, apartado 1, segundo párrafo, del Reglamento n° 1308/70 limita la ayuda otorgada por la Comunidad al cáñamo producido a partir de semillas de variedades que ofrezcan **determinadas garantías en lo referente al contenido en sustancias embriagantes del producto cosechado. Estas garantías están determinadas en el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n° 619/71, que establece el contenido máximo en THC admisible para que el cáñamo pueda beneficiarse de ayuda comunitaria.**

36 De todo ello se deriva que los Reglamentos nos 1308/70 y 619/71 se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el asunto principal” (la negrita es nuestra).

Conviene mencionar, por último, que el límite para la importación del cáñamo dentro de la Unión, fijado ahora en un 0,3%, está actualmente sometido a una nueva negociación, y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo ya ha acordado proponer un aumento de dicho umbral al 0,5% de THC.

Todo ello en coherencia con los esfuerzos de la Unión por reducir la fiscalización internacional del cannabis con bajo contenido de THC, con base en las conclusiones más recientes de la comunidad científica internacional que insisten en que el CBD no tiene efectos perjudiciales para la salud.

En definitiva, el fundamento científico ofrecido por la Administración para justificar el establecimiento del umbral del 0,2% de THC para clasificar los preparados estandarizados de cannabis como psicótrópos se reduce a unos supuestos ensayos clínicos cuyos informes no constan en el expediente administrativo (tras haber sido solicitados) y en la recomendación (tergiversada) de un Informe del Comité de Expertos de la OMS que fue rechazada. Establecer un umbral de THC para someter a fiscalización el cannabis medicinal carece de fundamento científico y por ello no está previsto ni en los instrumentos internacionales vigentes ni en el derecho comparado. Incluso cuando pueda resultar relevante establecer un umbral de THC para determinar la fiscalización del cannabis (como ocurre habitualmente cuando se regula para otros fines), éste debe aplicarse para reducir el nivel de fiscalización internacional (esto es, desclasificar el CBD como estupefaciente), y no para aumentarlo (someter el cannabis a la fiscalización propia de la Convención sobre Sustancias Sicotrópicas); y, en cualquier caso, dicho umbral debe situarse por encima del 0,2%.

5. El artículo 3 del Real Decreto vulnera el principio de cooperación leal establecido en el artículo 4.3 del TUE al contravenir el espíritu de la Decisión (UE) 2021/3 del Consejo.

Mediante la Decisión (UE) 2021/3 del Consejo, la Unión adoptó una Posición Común dirigida, en esencia, a reducir la fiscalización internacional del cannabis medicinal. Bajo esta perspectiva, uno de los ejes principales de la

Posición Común fue apoyar la recomendación de que las diferentes variedades de THC que se encuentran actualmente sujetas a fiscalización bajo la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas pasen a someterse únicamente a la Convención sobre Estupefacientes.

Por su parte, la recomendación de aplicar este mismo tratamiento a otros isómeros del THC obedece a cuestiones prácticas dirigidas a garantizar que se aplique la misma fiscalización de sustancias que tienen estructuras y propiedades químicas similares, tal como se explica en este mismo Informe (**folios 3318 y ss. del expediente**) y en el considerando 17 de la Decisión (UE) 2021/3 del Consejo.

Además, el Comité de Expertos sugirió excluir a su vez dichas sustancias de la fiscalización bajo la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas con el fin de evitar que una misma sustancia esté sometida a una doble fiscalización internacional (**folios 3318 y 3321 del expediente**). Esta recomendación también fue completamente acogida por la Decisión (UE) 2021/3 del Consejo, cuyo apartado 20 dispone:

“A fin de velar por la coherencia de la inclusión en las listas del delta-9-tetrahidrocannabinol y de su estereoisómero activo dronabinol, así como del tetrahidrocannabinol (isómeros de delta-9-tetrahidrocannabinol), y de **evitar el riesgo de que alguna de esas sustancias esté incluida en una lista de la Convención sobre Estupefacientes a la vez que en una lista del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas**, debe ser posible que los Estados miembros que participan en la Comisión de Estupefacientes en calidad de miembros expresen en una votación conjunta la posición de la Unión respecto a la inclusión de esas sustancias” (la negrita es nuestra).

Teniendo en cuenta este contexto, es evidente que el artículo 3 del Real Decreto es frontalmente contrario a los objetivos perseguidos por la Posición Común de la Unión. Y ello por varios motivos.

Primero, porque mientras la Unión trata de lograr que los preparados de cannabis se fiscalicen únicamente como estupefacientes, el artículo 3 del Real Decreto somete los preparados de cannabis que superen una determinada concentración de THC (con un umbral muy bajo y no justificado, como ya hemos visto) a la fiscalización de psicótrpos.

Segundo, porque con ello se produce una doble fiscalización de estos preparados como estupefacientes y psicótrpos (tal como se desprende de los apartados 4 y 5 del artículo 5), resultado que la Unión también pretendía evitar.

Esta flagrante desviación respecto de la Posición Común de la Unión debe considerarse una vulneración del principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea.

Así se desprende de la reciente Sentencia dictada el 27 de enero de 2026 por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-271/23, a la que ya nos hemos referido, en particular, los apartados 32 y 33 de la misma.

Es decir, el Tribunal de Justicia ha declarado expresamente que la obligación de cooperación leal que se impone a los Estados Miembros en relación con la Posición Común de la Unión no se limita a cumplir lo estrictamente acordado por el Consejo – esto es, a votar conforme a lo acordado en la Decisión (UE) 2021/3 del Consejo durante la continuación de la 63ª sesión de la Convención de Estupefacientes –, sino que se extiende a la abstención de toda conducta que pueda poner en peligro los objetivos estratégicos de dicha posición.

Aplicando estas consideraciones al caso que nos ocupa, la decisión unilateral de la Administración de someter el cannabis medicinal a un nivel de fiscalización mucho más estricto de lo necesario, a sabiendas de que los objetivos estratégicos de la Unión definidos en la Decisión 2021/3 respecto a la adecuada regulación del cannabis medicinal son diametralmente opuestos a tal situación, debe considerarse igualmente una vulneración del principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4.3 TUE.

6. El artículo 3 del Reglamento contraviene el principio de libre circulación de bienes.

Además de todo lo anterior, como explicaremos a continuación, el artículo 3 del Reglamento al disponer que todo preparado estandarizado que contenga un 0,2% de THC se considera un psicótropo y está sometido a las reglas del Real Decreto 2829/1977, acarrea una restricción injustificada a la libre circulación de bienes, por mor del juego de este artículo con los apartados segundo, cuarto y quinto del artículo 5 del Reglamento impugnado.

TERCERO.- El artículo 5 en relación con el 3 del Reglamento vulnera la libertad de circulación de mercancías en la Unión consagrada en los artículos 28 y 34 del TFUE.

La clasificación establecida en el artículo 3 del Real Decreto tiene importantes consecuencias para la fiscalización de los preparados estandarizados de cannabis. Una de estas consecuencias se manifiesta en el artículo 5 del Real Decreto, que impone determinadas obligaciones a los laboratorios farmacéuticos fabricantes de preparados estandarizados de cannabis que, según su apartado 1, deberán estar establecidos en la Unión Europea.

Para empezar, el apartado 2 del artículo 5 impone a los laboratorios fabricantes la siguiente obligación sobre las garantías que deben cumplir respecto al “material de partida” que utilicen para fabricar sus preparados:

“2. Los laboratorios farmacéuticos fabricantes tienen la obligación de asegurar el cumplimiento de las normas de correcta fabricación y buenas prácticas de distribución por los proveedores o fabricantes de materiales de partida empleados en la fabricación de los preparados estandarizados. A tal fin, se deberán auditar a intervalos regulares a dichos proveedores o fabricantes. Deberán, asimismo, **documentar la cadena de suministro de cada material de partida, que deberá tener un origen lícito y cumplir con la legislación aplicable a las sustancias estupefacientes y/o psicótropas, según proceda**” (la negrita es nuestra).

Además, los apartados 4 y 5 del artículo 5 imponen las siguientes obligaciones relativas a la obtención de licencia de psicótopos y (en su caso) de estupefacientes:

“4. Cuando estos preparados se consideren psicótopos en virtud de su contenido en THC, conforme al artículo 3, los laboratorios farmacéuticos fabricantes deberán contar con la correspondiente autorización, conforme a lo previsto en el Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre.

5. Asimismo, cuando estos fabricantes hayan obtenido preparados psicótopos a partir de sustancias estupefacientes (cannabis) deberán contar con la correspondiente autorización conforme a lo previsto en la Ley 17/1967, de 8 de abril, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes y adaptándolas a lo establecido en el convenio de 1961 de las Naciones Unidas”.

Es decir, se somete a los fabricantes de preparados estandarizados de cannabis, establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión, a la obligación de obtener dos autorizaciones de fabricación: una licencia de psicótopos (prevista en el artículo 6 del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre) y una licencia de estupefacientes (prevista en el artículo 11 de la Ley 17/1967).

Estas previsiones contravienen la libertad de circulación de mercancías dentro de la Unión consagrada en el artículo 34 TFUE, y no puede justificarse objetivamente bajo el artículo 36 TFUE.

1. **La sujeción de la fabricación de los preparados de cannabis a una licencia de psicótrópos y (en su caso) de estupefacientes constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación en el sentido del artículo 34 TFUE.**

El artículo 34 TFUE prohíbe a los Estados Miembros establecer “*restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente*”.

Según la jurisprudencia comunitaria, la prohibición de establecer “medidas de efecto equivalente” a las restricciones cuantitativas a la importación se refiere a cualquier normativa comercial de los Estados miembros que pueda obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio dentro de la Unión (véanse, entre muchas otras, las Sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1974, *Dassonville*, 8/74, Rec. p. 837, apartado 5; de 23 de septiembre de 2003, *Comisión/Dinamarca*, C-192/01, Rec. p. I-9693, apartado 39, y de 5 de febrero de 2004, *Comisión/Francia*, C-24/00, Rec. p. I-1277, apartado 22).

En particular, una medida de efecto equivalente en el sentido del artículo 34 TFUE puede consistir en una norma nacional que imponga determinados requisitos para la comercialización de un bien producido en otro Estado Miembro donde no se exijan legalmente tales requisitos. Así lo estableció el Tribunal de Justicia en el famoso asunto *Cassis de Dijon* (Sentencia de 20 de

febrero de 1979 dictada en el asunto 120/78), que declaró que el requisito mínimo de graduación alcohólica para comercializar ciertos productos como bebidas alcohólicas en Alemania no podía obstaculizar la comercialización de un producto que superaba la graduación mínima establecida en Francia.

Para el caso que nos ocupa, resulta especialmente relevante la jurisprudencia establecida en el asunto *Evans Medical* (Sentencia del 28 de marzo de 1995 dictada en el asunto C-324/93), en la que el Tribunal de Justicia clarificó la relación entre la libertad de circulación consagrada en el artículo 34 TFUE (entonces artículo 30 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, “**Tratado CEE**”) y la fiscalización internacional que establecen la Convención de Estupefacientes de 1961 y la Convención sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.

Esta sentencia tuvo por objeto la normativa británica que sujetaba la importación de diamorfina a la obtención de una autorización por parte de la autoridad nacional competente. La diomorfina es un derivado del opio, y como tal estaba fiscalizada bajo la Convención de Estupefacientes de 1961. La empresa británica Generics (UK) Ltd. solicitó una autorización para importar diamorfina procedente de Países Bajos, pero fue denegada por la autoridad nacional competente. La entidad británica interpuso recurso jurisdiccional contra la resolución que denegó la autorización con el fin de que la normativa británica que la exigía se declarara contraria a la libre circulación consagrada en el entonces artículo 30 del Tratado CEE, y que no podía justificarse bajo su artículo 36. Sin embargo, el Reino Unido argumentó que su conducta estaba amparada bajo el artículo 234 del Tratado CEE (hoy, artículo 351 TFUE), que salvaguarda los derechos y obligaciones que resulten de los convenios celebrados por los Estados Miembros con anterioridad a su adhesión a los Tratados de la Unión.

El órgano jurisdiccional nacional planteó cuestión prejudicial con el fin de aclarar la relación entre el Convenio de Estupefacientes de 1961 y los artículos 30, 36 y 234 del Tratado CEE. Y el Tribunal de Justicia resolvió la cuestión declarando que los Estados Miembros no pueden aplicar medidas de fiscalización más estrictas de lo que exige el cumplimiento de sus obligaciones bajo dicha Convención cuando dichas medidas vulneren la libertad de circulación intracomunitaria:

“31. Durante el procedimiento, el Gobierno del Reino Unido alegó que la Convención permitía que los Estados signatarios prohibieran la importación de estupefacientes en su territorio, **pero que no les exigía que adoptaran dicha medida.**

32. A este respecto, hay que destacar que, **cuando un Convenio internacional permite que un Estado miembro adopte una medida que es contraria al Derecho comunitario, pero sin obligarle, el Estado miembro debe abstenerse de adoptar dicha medida.**

33. Por consiguiente, procede responder a dicha cuestión que el artículo 30 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que **un Estado miembro debe garantizar la plena eficacia de dicha disposición dejando inaplicada una práctica nacional contraria, salvo si dicha práctica es necesaria para garantizar la ejecución, por parte del Estado miembro de que se trata, de obligaciones frente a Estados terceros derivadas de un Convenio celebrado con anterioridad a la entrada del vigor del Tratado o a la adhesión de un Estado miembro**” (la negrita es nuestra)

Aplicando la doctrina *Evans Medical* al caso que nos ocupa, se desprende la siguiente conclusión: si se demuestra que las licencias a las que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 5 del Real Decreto constituyen una medida de fiscalización más estricta de lo necesario para dar cumplimiento a las obligaciones del Reino de España bajo las Convenciones de 1961 y 1971, y esta previsión restringe la importación de un preparado legalmente producido en otro Estado Miembro, entonces esta regulación constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa prohibida por el artículo 34 TFUE.

Ahora bien, para interpretar el alcance de las obligaciones de fiscalización internacional que imponen ambas Convenciones en relación con la libertad de circulación en la Unión, es necesario hacer referencia a la Sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto *Kanavape* (Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2020, asunto C-663/18), que fue invocada en numerosas ocasiones durante la tramitación del proyecto.

Esta Sentencia resolvió una cuestión prejudicial que tuvo como objeto la condena penal de dos ciudadanos franceses por la comercialización de un cigarrillo electrónico que contenía CBD que había sido importado de República Checa, donde se había producido cumpliendo la normativa nacional. Concretamente, el Tribunal constató que el CBD no se encuentra fiscalizado por la Convención sobre Sustancias Sicotrópicas y añadió que, bajo una interpretación teleológica de la Convención de Estupefacientes de 1961 aplicando las normas de interpretación de los tratados que impone el derecho internacional, tampoco debe considerarse un estupefaciente:

“61. Dado que está prohibida la introducción de estupefacientes que no se encuentren en tal circuito rigurosamente controlado en el circuito económico y comercial de la Unión, las personas que comercialicen estos productos no pueden invocar la aplicación de las libertades de circulación o el principio de no discriminación por lo que respecta a la actividad consistente en la comercialización de cannabis (sentencia de 16 de diciembre de 2010, *Josemans*, C-137/09, EU:C:2010:774, apartado 42).

63 Por consiguiente, debe determinarse si el CBD controvertido en el litigio principal es un estupefaciente, en el sentido de la jurisprudencia citada en los apartados 59 a 62 de la presente sentencia.

64 A este respecto, **procede señalar que ni el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas ni la Acción Común 97/396, a las que se hace referencia en el artículo 1, punto 1, letra b), de la Decisión Marco 2004/757, incluyen esta sustancia en su ámbito.**

65. Por ello, es preciso determinar si el CBD controvertido en el litigio principal está contemplado en la Convención Única, a la que se hace referencia en el artículo 1, punto 1, letra a), de la Decisión Marco 2004/757 y a la que también se alude en el artículo 71, apartado 1, del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen.

66. Por lo que se refiere a la **interpretación de un convenio internacional, como la Convención Única, procede recordar que, según una jurisprudencia reiterada, un tratado internacional ha de interpretarse en función de los términos en que está redactado, así como a la luz de sus objetivos**. Los **artículos 31 del Convenio de Viena**, de 23 de mayo de 1969, sobre el Derecho de los Tratados (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1155, p. 443), y del Convenio de Viena, de 21 de marzo de 1986, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, vol. II, p. 95), que **expresan el Derecho internacional general consuetudinario en este sentido**, establecen, a este respecto, que un tratado debe **interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin de este** (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de enero de 2006, IATA y ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, apartado 40).

67. Del preámbulo de la Convención Única se desprende que las partes se declaran, en particular, preocupadas por la salud física y moral de la humanidad, así como conscientes de la obligación que les incumbe de prevenir y combatir la toxicomanía.

68. A tenor del artículo 1, apartado 1, letra j), de la Convención Única, el término «estupefaciente» designa cualquier sustancia de las listas I y II de dicha Convención, naturales o sintéticas. En la lista I de la citada Convención figuran, en particular, el cannabis, la resina de cannabis y los extractos y tinturas de cannabis.

69. Además, los términos «cannabis» y «planta de cannabis» se definen en el artículo 1, apartado 1, letras b) y c), de la Convención Única respectivamente como «las sumidades, floridas o con fruto, de la planta de la cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe», y como «toda planta del género cannabis».

70. En el presente asunto, de los autos que obran en el Tribunal de Justicia se desprende que el CBD controvertido en el litigio principal se extrae de la planta Cannabis sativa en su totalidad y no solo de las semillas y hojas de esta planta, a excepción de sus sumidades floridas o con fruto.

71. En estas circunstancias, es cierto que una interpretación literal de las disposiciones de la Convención Única podría llevar a la conclusión de que, en la medida en que el CBD se extrae de una planta del género cannabis y que esta planta se utiliza en su totalidad, incluidas sus sumidades floridas o con fruto, este es un extracto de cannabis, en el sentido de la lista I de dicha Convención, y, por consiguiente, un «estupefaciente», en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra j), de la citada Convención.

72. No obstante, es preciso señalar que de los autos que obran en el Tribunal de Justicia y que se resumen en el apartado 34 de la presente sentencia se desprende que el CBD controvertido en el litigio principal no parece tener efectos psicotrópicos ni nocivos para la salud humana sobre la base de los datos

científicos disponibles. Además, según estos elementos de los autos, la variedad de cannabis de la que se extrajo esta sustancia, que fue cultivada legalmente en la República Checa, tiene un contenido en THC que no supera el 0,2 %.

73. Pues bien, como se desprende del apartado 67 de la presente sentencia, **la Convención Única se basa, en particular, en una finalidad de protección de la salud física y moral de la humanidad. Por consiguiente, debe tenerse en cuenta este objetivo al interpretar las disposiciones de dicha Convención.**

74. Este enfoque se impone tanto más cuanto que una lectura de los comentarios a la Convención Única publicados por la Organización de las Naciones Unidas relativos a la definición de «cannabis» a efectos de dicha Convención lleva a la conclusión de que, habida cuenta del objetivo y del espíritu general de la citada Convención, tal definición está intrínsecamente vinculada al conocimiento científico actual de la nocividad para la salud humana de los productos derivados del cannabis. A título ilustrativo, de estos comentarios se desprende, en particular, que la exclusión de la definición del cannabis, que figura en el artículo 1, apartado 1, letra b), de la misma Convención, de las sumidades floridas o con fruto de las cuales se ha extraído la resina estaba justificada por la circunstancia de que dichas sumidades solo contienen una cantidad totalmente insignificante del principio psicoactivo.

75. A la vista de estos elementos, que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente, procede considerar que, **dado que el CBD no contiene un principio psicoactivo en el estado actual de los conocimientos científicos recordados en el apartado 34 de la presente sentencia, sería contrario a la finalidad y al espíritu general de la Convención Única incluir este en la definición de «estupefacientes», en el sentido de dicha Convención, como extracto de cannabis.**

76. De ello se deduce que el CBD controvertido en el litigio principal no es un estupefaciente, en el sentido de la Convención Única.

77. Por otra parte, cabe añadir que, como ha señalado también la Comisión, el CBD controvertido en el litigio principal **se produjo y comercializó legalmente en la República Checa.**

78. A la luz de todas las consideraciones anteriores, **procede concluir que los artículos 34 TFUE y 36 TFUE son aplicables al CBD controvertido en el litigio principal**” (la negrita es nuestra).

Siguiendo este mismo razonamiento, en su Propuesta de 16 de julio de 2025 para la modificación del ya citado Reglamento (UE) nº 1308/2013 en el marco de la PAC, la Comisión Europea ha indicado que la insistencia de algunos Estados Miembros en adoptar restricciones a los productos de cáñamo produce una barrera en el mercado interior que no pueden justificarse bajo los convenios

internacionales aplicables porque los productos de CBD con bajo componente de THC no deben considerarse estupefacientes:

“(20) Algunos Estados miembros han adoptado medidas nacionales para prohibir la producción o la comercialización de determinados productos de cáñamo por motivos de protección de la salud. **Esta divergencia en los enfoques nacionales** socava el correcto funcionamiento de la organización común de mercados, crea inseguridad jurídica y **barreras en el mercado interior** y genera competencia desleal entre los agricultores de los distintos Estados miembros.

(21) De conformidad con diversos instrumentos internacionales en los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido, como la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, debe prohibirse la comercialización de estupefacientes, con excepción del comercio estrictamente controlado o de la utilización para fines médicos y científicos. Sin embargo, **del razonamiento del Tribunal en el asunto C-663/1826 se desprende que los productos no psicoactivos, como el cannabidiol, procedentes de variedades de cáñamo con un bajo contenido de Δ^9 -tetrahidrocannabinol no deben considerarse estupefacientes con arreglo a estos convenios**” (la negrita es nuestra).

Se entiende ahora por qué la Administración se vio obligada a eliminar el apartado 1 del artículo 3 del primer proyecto de Real Decreto, que afirmaba que el cannabis, independientemente de su contenido de CBD o THC, se considera un estupefaciente bajo la Convención de 1961. Afirmación que, además, encabezó el preámbulo del proyecto del Real Decreto hasta su penúltima versión (ver **folio 432 del expediente**), y solo fue eliminado en el texto definitivo.

Llama la atención, sin embargo, que ante las numerosísimas alegaciones que se formularon durante la tramitación del proyecto señalando que el apartado 1 del artículo 3 contradecía lo dispuesto en la Sentencia *Kanavape*, la Memoria de Impacto de Análisis Normativo (i) omite toda referencia expresa a dicha sentencia, incluso cuando recoge las alegaciones que la invocaron; (ii) insiste en su posición de que el cannabis siempre se debe considerar un estupefaciente

independientemente de su concentración de CBD o THC (por ejemplo, ver **folios 480, 484, 563-564 del expediente**); y (iii) no explica en ningún momento el cambio de criterio que determinó la eliminación de apartado 1 del artículo 3 y del primer párrafo del preámbulo.

Pero lo que resulta más relevante es que la supresión del apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto no conllevó la modificación del artículo 5, que sigue imponiendo una fiscalización que no es exigible bajo los convenios internacionales. Veamos por qué.

En cuanto al apartado 2º del artículo 5, este precepto establece que el **“material de partida”** deberá *“cumplir con la legislación aplicable a las sustancias estupefacientes y/o psicótropas, según proceda”*. De esta manera, la norma está asumiendo que ese material de partida, esa materia prima que se va a utilizar para realizar el preparado estandarizado, siempre y en todo caso, va a estar sujeto o bien a la Convención de 1961 o bien al Convenio de 1971 o bien a ambas normas. Sin embargo, dicho presupuesto no es cierto, tal y como evidencia el asunto *Kanavape*. El problema está, por tanto, que, atendiendo a este precepto, se estarían sometiendo a fiscalización sustancias que se encuentran extramuros de ambas normas.

En cuanto al apartado 4º del artículo 5º, en este precepto se establece lo siguiente: *“Cuando estos preparados se consideren psicótrapos en virtud de su contenido en THC, conforme al artículo 3, los laboratorios farmacéuticos fabricantes deberán contar con la correspondiente autorización, conforme a lo previsto en el Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre.”*. Es decir, el artículo exige una licencia de psicótropo a todos los laboratorios que utilicen materiales que se encuentran sujetos al artículo 3. El problema, como decimos, es que este artículo 3 es el que introduce innovativamente un porcentaje del 0,2% de THC

que no tiene parangón ni en los Tratados Internacionales ni en el Derecho comparado (véase Francia o Alemania, entre otros). De esta manera, el precepto está sometiendo a la fiscalización práctica propia del Convenio de 1971 a laboratorios que, atendiendo al propio tenor literal de dicho Convenio, no estarían sujetos al mismo; y, lo mismo si atendemos a las normas que rigen en otros Estados miembros, cuyos laboratorios sólo se sujetan a la fiscalización del Convenio de 1971 si trabajan con psicótopos.

Y, en cuanto al apartado 5º del artículo 5, este precepto establece lo siguiente: *“Asimismo, cuando estos fabricantes hayan obtenido preparados psicótopos a partir de sustancias estupefacientes (cannabis) deberán contar con la correspondiente autorización conforme a lo previsto en la Ley 17/1967, de 8 de abril, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes y adaptándolas a lo establecido en el convenio de 1961 de las Naciones Unidas.”*. En este caso, el problema es que el precepto está asumiendo que todo cannabis es, siempre y en todo caso, un estupefaciente, lo que, de nuevo, no es correcto. La consecuencia práctica de ello vuelve a ser la misma: someter a fiscalización sustancias que no debieran estar sometidas a la Convención de 1961.

De todo lo anterior se deduce que el 5 impone a los laboratorios fabricantes obligaciones de fiscalización más estrictas de lo que exige el cumplimiento del Convenio de Estupefacientes de 1961 y del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. Por tanto, estas previsiones constituyen una medida de efecto equivalente en el sentido del artículo 34 TFUE.

2. **La exigencia de las licencias previstas en el artículo 5 del Real Decreto no está objetivamente justificada bajo el artículo 36 TFUE.**

Por último, incluso cuando una determina medida nacional es en principio incompatible con el artículo 34 TFUE, el artículo 36 TFUE permite justificarla bajo determinados fines legítimos, incluida la protección de la salud. Así, es previsible que la Administración pretenda ampararse en esta excepción para tratar de justificar la restricción a la libertad de circulación de mercancías en la Unión que establece el artículo 5 del Real Decreto. No obstante, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esta restricción no puede justificarse objetivamente bajo el artículo 36 TFUE.

En efecto, el Tribunal de Justicia ha interpretado de manera estricta la excepción prevista en el artículo 36 TFUE, que exige que el Estado Miembro que la invoque justifique (i) la existencia de un riesgo real para la salud según los datos científicos más recientes; (ii) la idoneidad de la medida para hacer frente a dicho riesgo y (iii) el respeto al principio de proporcionalidad.

Así se establece, entre muchas otras, en la Sentencia de 28 de enero de 2010 dictada en el asunto C-333/08 (*Comisión Europea v. República Francesa*):

“87. Puesto que el artículo 30 CE **establece una excepción, de interpretación estricta, a la regla de la libre circulación de mercancías en el interior de la Comunidad**, incumbe a las autoridades nacionales que lo invocan demostrar en cada caso, habida cuenta de los resultados de la investigación científica internacional, que **su normativa es necesaria para proteger de un modo efectivo** los intereses contemplados en dicha disposición y, en especial, que la **comercialización de los productos de que se trata plantea un riesgo real para la salud pública** (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Comisión/Dinamarca, apartado 46, y de 5 de febrero de 2004, Comisión/Francia, apartado 53 y jurisprudencia citada).

88. Una prohibición de comercialización de AT o de productos alimenticios en cuya preparación se hayan utilizado AT legalmente fabricados y/o comercializados en otros Estados miembros **ha de basarse en un análisis detenido del riesgo alegado por el Estado miembro que invoca el artículo 30 CE** (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Comisión/Dinamarca, apartado 47, y de 5 de febrero de 2004,

Comisión/Francia, apartado 54, así como la sentencia de 2 de diciembre de 2004, Comisión/Países Bajos, C-41/02, Rec. p. I-11375, apartado 48).

89. Una decisión de prohibir la comercialización, que constituye, además, el **obstáculo más restrictivo a los intercambios de productos legalmente fabricados y comercializados en otros Estados miembros**, sólo puede adoptarse si el riesgo real para la salud pública que se haya alegado **resulta suficientemente acreditado sobre la base de los datos científicos más recientes disponibles en la fecha de adopción de tal decisión**. En semejante contexto, el análisis del riesgo que el Estado miembro está obligado a realizar tiene por objeto apreciar el grado de probabilidad de que la utilización de AT en la preparación de productos alimenticios tenga efectos nefastos para la salud humana y la gravedad de dichos efectos potenciales (sentencias antes citadas Comisión/Dinamarca, apartado 48; de 5 de febrero de 2004, Comisión/Francia, apartado 55, y Comisión/Países Bajos, apartado 49).

90. Al ejercer su facultad de apreciación en materia de protección de la salud pública, **los Estados miembros deben respetar el principio de proporcionalidad**. Por tanto, **los medios que elijan han de limitarse a lo que sea efectivamente necesario para garantizarla protección de la salud pública** y han de ser **proporcionados al objetivo** así perseguido, que **no habría podido alcanzarse con medidas menos restrictivas** de los intercambios intracomunitarios (véanse las sentencias antes citadas Comisión/Dinamarca, apartado 45, y de 5 de febrero de 2004, Comisión/Francia, apartado 52)” (la negrita es nuestra).

Respecto a la evaluación de los riesgos para la salud, el Tribunal de Justicia también reconoció que el principio de cautela concede a los Estados Miembros cierta facultad de apreciación que les permite aplicar medidas de protección en caso de incertidumbre sobre los efectos adversos para la salud que puede tener la comercialización de un producto en su territorio. Sin embargo, la aplicación de este principio exige que, tras un análisis detallado y global del riesgo para salud, persista un alto grado de incertidumbre científica, siendo insuficiente la mera alegación de perjuicios potenciales:

“91. Ciertamente, la evaluación que el Estado miembro está obligado a efectuar podría demostrar que hay un **elevado grado de incertidumbre científica y práctica al respecto**. Tal incertidumbre, **inseparable del concepto de cautela**, influye en el alcance de la **facultad de apreciación del Estado miembro** y repercute, de esta forma, en los modos de aplicación del principio de proporcionalidad. En esas circunstancias **debe admitirse que un Estado miembro, en virtud del principio de cautela, puede adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestren plenamente la realidad y la gravedad de**

tales riesgos (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de mayo de 1998, National Farmers' Union y otros, C-157/96, Rec. p. I-2211, apartado 63, y Comisión/Países Bajos, antes citada, apartados 51 y 52). Sin embargo, el análisis del riesgo no puede basarse en consideraciones puramente hipotéticas (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de septiembre de 2003, Monsanto Agricultura Italia y otros, C-236/01, Rec. p. I-8105, apartado 106; Comisión/Dinamarca, antes citada, apartado 49, y Comisión/Países Bajos, apartado 52).

92 Una aplicación correcta del principio de cautela presupone, en primer lugar, **la identificación de las consecuencias negativas que puede tener para la salud** la adición propuesta de AT y, en segundo lugar, **un análisis global del riesgo para la salud basado en los datos científicos más fiables de que se disponga y en los resultados más recientes**.

93. Cuando **resulta imposible determinar con certeza la existencia o el alcance del riesgo alegado por razón de la naturaleza insuficiente**, no concluyente o imprecisa de los resultados de los estudios realizados y, sin embargo, persiste la **probabilidad de un perjuicio real para la salud pública** en el supuesto en que ocurra el riesgo, el principio de cautela justifica la adopción de medidas restrictivas, siempre y cuando sean objetivas y no discriminatorias (véanse las sentencias antes citadas, Comisión/Dinamarca, apartado 52, y Comisión/Países Bajos, apartado 54).

94. En el presente asunto, la República Francesa justifica el procedimiento de autorización previa impuesto por su normativa escudándose en los riesgos potenciales que presentan para la salud determinadas categorías de AT.

95. Sin embargo, si bien existen riesgos respecto de determinadas categorías de AT, la normativa nacional debe estar enfocada y claramente justificada respecto a dichas categorías y no debe contemplar todos los AT ni todos los productos alimenticios en cuya preparación se hayan utilizado AT no comprendidos en esas categorías peligrosas o sospechosas. **No es suficiente basarse en los riesgos potenciales que representan las sustancias o los productos sometidos a autorización**” (la negrita es nuestra).

Por último, el Tribunal señaló que no es proporcionada una normativa nacional que someta indistintamente a autorización todo tipo de productos incluidos bajo una amplia definición, comercializados legalmente en otros Estados Miembros, sin permitir la evaluación del riesgo para la salud que pueda suscitar un determinado producto, caso por caso:

“99 Como se desprende del apartado 90 de la presente sentencia, para respetar el principio de proporcionalidad, **los medios que los Estados miembros elijan han de limitarse a lo que sea efectivamente necesario para garantizar la protección de la salud**.

100 El examen de los autos a la luz del **régimen de autorización previa** previsto por el Decreto de 1912 revela que **éste es desproporcionado en la medida en que, salvo autorización previa, se prohíbe sistemáticamente la comercialización** de todo AT o de todo producto alimenticio en cuya preparación se hayan utilizado AT fabricados y/o comercializados legalmente en otros Estados miembros, sin hacer distinciones en función de los diferentes AT o del nivel de riesgo para la salud que su utilización pueda presentar eventualmente” (la negrita es nuestra).

101. Por su carácter sistemático, el Decreto de 1912 no permite respetar el Derecho comunitario en lo que respecta a la identificación previa de los efectos nocivos de los AT y a la **evaluación del riesgo real para la salud que presentan, riesgos que exigen un examen en profundidad**, caso por caso, de los efectos que podría llevar aparejada la utilización de los AT en cuestión” (la negrita es nuestra).

Además, en el ya citado asunto *Ulf Hammarsten*, que tuvo por objeto la prohibición nacional en Suecia al cultivo de cáñamo, el Tribunal señaló que un Estado Miembro no puede invocar la excepción del artículo 36 TFUE invocando riesgos para la salud que ya hayan sido tenidos en cuenta en el Derecho comunitario:

“32. Debe señalarse, por otro lado, que **la normativa sueca relativa a los estupefacientes no persigue un objetivo de interés general que no esté cubierto por la organización común de mercados en el sector del cáñamo.**

33. El Gobierno sueco alega, a este respecto, que la normativa nacional controvertida es necesaria para lograr el objetivo de protección de la vida y la salud de las personas y que está justificada por el hecho de que el cannabis constituye un estupefaciente según la Convención de la Organización de Naciones Unidas de 1961 sobre estupefacientes. Según este Gobierno, las normas comunitarias en materia de agricultura, como las de la organización común de mercados establecida en el sector del cáñamo, tienen un objetivo distinto del perseguido por la normativa sueca, que es el de garantizar un nivel elevado de protección de la salud pública.

34. Sin embargo, **se desprende de los dos primeros considerandos del Reglamento n° 1430/82 que los riesgos para la salud humana que implica el uso de estupefacientes se tuvieron en cuenta expresamente en el marco de la organización común de mercados en el sector del cáñamo.**

35. En este sentido, el artículo 4, apartado 1, segundo párrafo, del Reglamento n° 1308/70 limita la ayuda otorgada por la Comunidad al cáñamo producido a partir de semillas de variedades que ofrezcan determinadas garantías en lo referente al contenido en sustancias embriagantes del producto cosechado. Estas garantías están determinadas en el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n° 619/71, que establece el contenido máximo

en THC admisible para que el cáñamo pueda beneficiarse de ayuda comunitaria.

36. De todo ello se deriva que los Reglamentos nos 1308/70 y 619/71 se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el asunto principal.

37. En estas circunstancias, **no resulta necesario en ningún caso examinar la pertinencia, en el presente asunto, de otras disposiciones de Derecho comunitario, tales como los artículos 28 CE a 30 CE** (la negrita es nuestra).

Por último, en *Kanavape*, el Tribunal indicó que, al aplicar la jurisprudencia establecida en el asunto *Comisión vs. República Francesa* a una norma nacional que fiscalice el tráfico de derivados de los cannabis sujetos a libertad de circulación dentro de la Unión, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios para evaluar la idoneidad de la medida y la evaluación de los riesgos para la salud:

“93. Efectivamente, al órgano jurisdiccional remitente le corresponde apreciar si la prohibición de comercializar el CBD legalmente producido en otro Estado miembro, cuando se extrae de la planta *Cannabis sativa* en su totalidad y no únicamente de sus fibras y semillas, es adecuada para garantizar la realización del objetivo de la protección de la salud pública y no excede de lo necesario para alcanzarlo a la luz de la jurisprudencia citada en los apartados 83 a 92 de la presente sentencia. No obstante, incumbe al Tribunal de Justicia proporcionarle todas las indicaciones necesarias para guiarle en esta apreciación.

94. Por lo que respecta a la apreciación de la cuestión **de si esta prohibición es adecuada para garantizar la realización del objetivo de protección de la salud pública**, procede señalar que en la vista se puso de manifiesto que dicha prohibición no afectaría a la comercialización del CBD de síntesis que tuviera las mismas propiedades que el CBD extraído de la planta *Cannabis sativa* en su totalidad y que pudiera utilizarse como sustituto de este último. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar esta circunstancia, que, de demostrarse, **podría indicar que la normativa analizada en el litigio principal no es adecuada para alcanzar, de manera coherente y sistemática, ese objetivo.**

95 En lo que atañe a la necesidad de la prohibición de comercializar el CBD cuando este se extrae de la planta *Cannabis sativa* en su totalidad y no solo de sus fibras y semillas, procede señalar que la República Francesa no está obligada a demostrar que la propiedad peligrosa de tal producto sea idéntica a la de estupefacientes tales como las sustancias que figuran en las listas I y II de la Convención Única. Con todo, corresponde al órgano jurisdiccional remitente

apreciar los datos científicos disponibles y aportados ante él para asegurarse, a la luz de la jurisprudencia citada en los apartados 88 a 92 de la presente sentencia y habida cuenta de las consideraciones expuestas en el apartado 72 de esta sentencia, de que **el riesgo real alegado para la salud pública no se base en consideraciones puramente hipotéticas**” (la negrita es nuestra).

Aplicando esta jurisprudencia, se observa que ninguno de los presupuestos para la aplicación del artículo 36 TFUE concurre en el presente caso. Para empezar, los hallazgos más recientes de la comunidad científica han demostrado que el cannabis medicinal puede tener efectos favorables para la salud, y que el consumo de preparados que contienen fundamentalmente CBD (con bajo contenido de THC) no presenta riesgos sustanciales para la salud; ello ha determinado, precisamente, que las últimas recomendaciones de la OMS se dirijan a reducir, y no incrementar, la fiscalización internacional del cannabis medicinal, como ya hemos visto.

Por si hubiese alguna duda, así lo resalta la ya citada Propuesta de la Comisión para la modificación de la normativa de la PAC, que apoya el establecimiento de un límite del 0,3% THC para la fiscalización del cáñamo industrial con base en que los productos por debajo de ese umbral no presentan riesgos significativos para la salud:

“Las pruebas científicas también apuntan a que es poco probable que los productos de cáñamo procedentes de variedades con un contenido máximo de tetrahidrocannabinol del 0,3 % supongan un riesgo para la salud humana. Por consiguiente, para garantizar la seguridad jurídica, promover el desarrollo del sector, garantizar condiciones de competencia equitativas en toda la Unión, apoyar el correcto funcionamiento de la organización común de mercados y, al mismo tiempo, proteger la salud pública, es necesario establecer normas armonizadas a escala de la Unión para la producción y comercialización de productos agrícolas de cáñamo que ofrezcan garantías en materia de salud pública. En particular, estas normas deben imponer un límite máximo uniforme del contenido de tetrahidrocannabinol, así como otras salvaguardias adecuadas”.

Siendo éste el estado de la cuestión, parece imposible que la Administración pueda demostrar, con base en datos científicos, que una regulación extraordinariamente estricta del cannabis medicinal se justifique bajo un riesgo real para la salud.

En cualquier caso, es evidente que los posibles riesgos para la salud que puedan derivarse del consumo excesivo o no controlado del cannabis medicinal ya se han tenido en cuenta para la adopción de la Posición Común de la Unión en la Decisión (UE) 2021/3 del Consejo. Por tanto, la Administración no puede justificar una medida que contraviene lo dispuesto en un instrumento del Derecho de la Unión invocando un objetivo que ya ha sido suficientemente abordado por dicho instrumento.

Por último, incluso si la Administración consiguiera demostrar la existencia de riesgos para la salud no contemplados bajo el Derecho de la Unión, la fiscalización establecida mediante el Real Decreto en su conjunto es inidónea para hacer frente a dichos riesgos, pues, como ya hemos señalado en los fundamentos anteriores, no guarda ninguna coherencia ni con el Derecho de la Unión ni con el sistema internacional de fiscalización vigente. Y, en cualquier caso, es desproporcionada, pues somete indistintamente a autorización de psicótopos y de estupefacientes los preparados de cannabis producidos legalmente en otros Estados Miembros, sin posibilitar una evaluación casuística de los riesgos para la salud que pueda presentar el preparado.

En definitiva, las restricciones a la libertad de circulación dentro de la Unión que se establecen bajo los apartados 2º, 4º y 5º del artículo 5, en relación con el artículo 3 del Real Decreto, no pueden justificarse bajo el artículo 36 TFUE.

CUARTO.- Los artículos 8 y 9.1 son contrarios al principio de proporcionalidad y al principio de libertad de empresa.

Los artículos 8 y 9 del Real Decreto 903/2025, de 7 de octubre, circunscriben el circuito de elaboración y dispensación exclusivamente en el ámbito de la farmacia hospitalaria, excluyendo a las oficinas de farmacia comunitarias.

Dicha exclusión constituye una restricción reglamentaria no prevista en la ley, carente de justificación suficiente y contraria al principio de proporcionalidad, así como a los principios de necesidad, eficacia y menor restricción.

En las respuestas a las alegaciones de distintas asociaciones el Ministerio justifica dicha exclusión en las recomendaciones dadas por la subcomisión del Congreso y en la necesidad de farmacovigilancia. Acompañamos extracto de las alegaciones del Ministerio, **folio 79 del expediente**:

“El proyecto de Real Decreto no contempla esta posibilidad teniendo en cuenta las conclusiones de la Subcomisión al efecto de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal, que fue creada a petición de la Comisión de Sanidad y Consumo en su sesión de 13 de mayo de 2021, Las indicaciones propuestas requieren un seguimiento farmacoterapéutico, que se realiza mayoritariamente en ámbito hospitalario, por lo que se considera que limita la elaboración y dispensación por servicios de farmacia hospitalaria está justificado.”

Estas alegaciones carecen de base. En primer lugar, no es cierto que la subcomisión vedase la posibilidad de dispensación en farmacias comunitarias. Al contrario, las mencionó expresamente en sus consideraciones, **folio 3264 del expediente**:

“3.6 La dispensación de fórmulas magistrales con extractos o preparados estandarizados de cannabis ha de realizarse a partir de la red de farmacias del sistema de salud, con preferencia en las farmacias hospitalarias y **explorando la alternativa de las farmacias comunitarias que puedan reunir los requisitos.**”

Por otra parte, conviene notar que la limitación de estos preparados a farmacias hospitalarias constituye una restricción del principio de libertad de empresa que carece de amparo normativo.

En efecto, incluso se podría considerar que es contrario a la normativa de medicamentos. No hay ningún precepto en la normativa española que permita limitar las fórmulas magistrales a farmacias hospitalarias.

La ley del medicamento no contiene ninguna previsión expresa respecto de fármacos limitados a uso hospitalario, es cierto que el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, faculta a la AEMPS a designar determinados fármacos como uso hospitalario, pero lo hace únicamente respecto de los fármacos de fabricación industrial y no con respecto a las fórmulas magistrales. Es más, la normativa sobre fórmulas magistrales, el Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales, define como “fórmula magistral”, punto 6 de su apartado de definiciones, aquella que se dispensa en una farmacia:

“6. Fórmula magistral: el medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por el farmacéutico, o bajo su dirección, para cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de las sustancias medicinales que incluye, según las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico, dispensado en su farmacia o servicio farmacéutico y con la debida información al usuario.”

La jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo ha establecido de forma reiterada que toda medida restrictiva de derechos o de acceso a prestaciones públicas debe superar el triple juicio de proporcionalidad.

La STC 39/2016, de 3 de marzo (BOE-A-2016-3405), reproduce literalmente la doctrina consolidada del Tribunal Supremo en los siguientes términos:

“(…) de conformidad con la doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: **si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)** [SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4 e), y 37/1998, de 17 de febrero, FJ 8]”.

Este canon resulta plenamente aplicable a una disposición reglamentaria que limita el acceso de los pacientes a un medicamento y excluye a un sector entero del sistema farmacéutico legalmente habilitado.

La oficina de farmacia es, por definición legal, un establecimiento sanitario sometido a control administrativo permanente, y resulta plenamente apta para la dispensación de medicamentos sujetos a especial control, como ocurre con estupefacientes y psicótrpos.

Por tanto, la exclusión no supera el juicio de idoneidad, al no demostrarse que el objetivo perseguido solo pueda alcanzarse mediante la dispensación hospitalaria.

El juicio de necesidad exige comprobar que no existen medidas alternativas menos restrictivas igualmente eficaces.

En el presente caso existen múltiples alternativas regulatorias menos gravosas: dispensación en oficina de farmacia con receta especial, formación específica del farmacéutico, sistemas reforzados de registro y seguimiento, visado o autorización previa o limitación a determinadas indicaciones o perfiles de paciente.

Ninguna de estas opciones ha sido evaluada ni descartada en la memoria normativa, lo que evidencia que la exclusión de la farmacia comunitaria no es necesaria, sino una opción reglamentaria desproporcionada y no justificada.

Por último, la exclusividad hospitalaria genera efectos negativos claros: reducción de la accesibilidad territorial, mayores cargas para pacientes crónicos, paliativos o con movilidad reducida, ruptura de la continuidad asistencial con el farmacéutico de referencia y sobrecarga de los servicios de farmacia hospitalaria.

Frente a estos perjuicios ciertos, no se acredita un beneficio adicional relevante en términos de seguridad o control respecto de la dispensación en oficina de farmacia. El sacrificio impuesto resulta, por tanto, excesivo y desequilibrado, vulnerando el juicio de proporcionalidad en sentido estricto exigido por la jurisprudencia constitucional.

La opción española resulta además anómala en el contexto europeo, como demuestra el derecho comparado. En Alemania, el § 3 del Medizinal-Cannabisgesetz (MedCanG) establece literalmente: «*Das nach Absatz 1 verschriebene Cannabis zu medizinischen Zwecken darf an Endverbraucherinnen und Endverbraucher nur im Rahmen des Betriebs einer Apotheke gegen Vorlage der Verschreibung abgegeben werden.*» Esto es “El cannabis prescrito con fines médicos de conformidad con el apartado 1 sólo podrá dispensarse a los consumidores finales en el marco del funcionamiento de una farmacia previa presentación de la receta”. Es decir, el cannabis medicinal solo puede dispensarse en farmacias (Apotheken), contra receta médica, sin exigencia de dispensación hospitalaria.

Mientras que en Francia, el Code de la santé publique, artículo L5121-1, define la preparación magistral en los siguientes términos: “*Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale (...) soit extemporanément en pharmacie*”. Esto es “Una preparación magistral es cualquier medicamento preparado según prescripción médica (...) ya sea de forma improvisada en una farmacia”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que las restricciones que limitan los canales de venta o dispensación de productos sanitarios deben superar un control estricto de proporcionalidad. Véase la sentencia de 2 de diciembre de 2010, *Ker-Optika* (C-108/09) y la sentencia *Josemans* (C-137/09).

Todo ello acredita en suma que el control sanitario puede articularse mediante canales farmacéuticos ordinarios, sin necesidad de imponer una restricción totalmente desproporcionada como la venta en farmacia hospitalaria.

En su virtud,

SUPLICO A LA SALA que teniendo por formulada la demanda, y por devuelto el expediente administrativo, dicte en su día Sentencia en la que estimando el presente recurso, declare la disconformidad a derecho del Real Decreto 903/2025, de 7 de octubre, por el que se establecen las condiciones para la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados de cannabis, en concreto los artículos 2.a), 2.c), 2.d), 3, 5.2, 5.4, 5.5, 8.1 y 8.2 y 9.1; todo ello, con expresa imposición de costas a la Administración demandada.

PRIMER OTROSÍ DIGO que siendo relevante para la resolución del presente recurso contencioso-administrativo la aclaración de determinados cuestiones de interpretación y validez del Derecho de la Unión Europea que resultan determinantes para la resolución del litigio principal, en particular, la conformidad a Derecho de los artículos 2, 3, 5, 8 y 9 del Real Decreto 903/2025, depende de la correcta interpretación de normas y principios del Derecho de la Unión relativos al alcance vinculante de la Decisión (UE) 2021/3 del Consejo; el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4.3 TUE; la libre circulación de mercancías (artículos 34 y 36 TFUE);

SUPLICO A LA SALA que plantee al respecto la correspondiente **CUESTIÓN PREJUDICIAL** al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el siguiente tenor:

1. ¿Debe interpretarse el artículo 288 TFUE, en relación con el artículo 4.3 TUE, en el sentido de que un Estado miembro vulnera el principio de cooperación leal cuando adopta una normativa interna que, aun sin contradecir formalmente, frustra los objetivos perseguidos por una

Decisión del Consejo que establece una posición común vinculante, como la Decisión (UE) 2021/3, en materia de fiscalización del cannabis y del THC?

2. ¿Se oponen los artículos 34 y 36 TFUE a una normativa nacional que clasifica como psicótrópos los preparados estandarizados de cannabis que superen un determinado porcentaje de THC (0,2 %), cuando dicho umbral no está previsto en el Derecho de la Unión, no resulta de los Convenios internacionales aplicables y da lugar a restricciones adicionales a la libre circulación de mercancías?
3. ¿Debe interpretarse la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la sentencia de 19 de noviembre de 2020 (asunto C-663/18, *Kanavape*), en el sentido de que una normativa nacional no puede someter a un régimen general de fiscalización a los preparados que contienen cannabidiol (CBD), sin un análisis caso por caso de sus efectos y de su riesgo real para la salud pública?
4. ¿Es compatible con el artículo 34 TFUE una normativa nacional que exige a los fabricantes establecidos en otros Estados miembros la obtención de licencias adicionales de estupefacientes y psicótrópos para la comercialización de preparados de cannabis legalmente producidos en dichos Estados, cuando tales exigencias no son estrictamente necesarias para cumplir obligaciones
5. ¿Debe interpretarse el principio de proporcionalidad, en relación con los artículos 34 y 36 TFUE, en el sentido de que se opone a una normativa nacional que limita exclusivamente al ámbito de la farmacia hospitalaria la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales con preparados de cannabis, excluyendo a las oficinas de farmacia comunitarias sin una justificación objetiva y suficiente?

SEGUNDO OTROSÍ DIGO que siendo relevante para la resolución del presente recurso contencioso-administrativo la acreditación de determinados puntos de hecho y al amparo del artículo 60.1 LJCA,

SUPlico A LA SALA que, en su momento, reciba el pleito a prueba, que deberá versar sobre la posición común de la Unión Europea acerca de la fiscalización del cannabis y de sus componentes.

TERCER OTROSÍ DIGO que, a los efectos previstos en el otrosí anterior y al amparo del artículo 60.1 LJCA, interesa al derecho de esta parte la práctica de los siguientes medios de prueba:

ÚNICA.- DOCUMENTAL, consistente en que se tengan por reproducidos en el ramo de prueba de esta parte, el expediente administrativo y los documentos anejos a este escrito.

CUARTO OTROSÍ DIGO que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.2 LJCA,

SUPlico A LA SALA que fije la cuantía del presente recurso como indeterminada.

QUINTO OTROSÍ DIGO que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.2 LJCA,

SUPlico A LA SALA que acuerde, en su momento, la presentación de conclusiones escritas.

SEXTO OTROSÍ DIGO que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138.2 LJCA, 231 LEC y 243.2 LOPJ, por medio del presente escrito manifiesto la voluntad de esta parte de cumplir los requisitos exigidos por la ley respecto a los actos procesales.

SUPlico A LA SALA que tenga por efectuada la anterior manifestación a los efectos de requerir, en su caso, la subsanación de los defectos en que incurran los actos procesales de esta parte.

Madrid, a la fecha de la firma electrónica

José María Baño Fos
Colg. ICAM nº 84.249